

Тема: Оказание первой помощи пострадавшим при травмах. Правила иммобилизации

При ранениях груди больного переносят: {

- ~%50% лежа на спине с выпрямленными ногами;
 - ~%50% лежа на спине с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами;
 - ~%50% лежа на животе;
 - =%100% сидя или в полусидячем положении;
 - ~%50% лежа на спине на твердой поверхности
- }

Оказание первой помощи при вывихе включает: {

- ~%50% прием обезболивающего;
 - ~%33.33333% прием снотворного;
 - ~%33.33333% вправление вывиха;
 - ~%50% холод на сустав;
 - ~%33.33333% тепло на сустав.
- }

Оказание первой помощи при вывихе включает: {

- ~%33.33333% прием снотворного;
 - ~%33.33333% вправление вывиха;
 - ~%33.33333% тепло на сустав;
 - ~%50% иммобилизацию сустава;
 - ~%50% доставку в больницу.
- }

Симптомы вывиха: {

- ~%50% вынужденное необычное положение конечности;
 - ~%33.33333% укорочение конечности;
 - ~%33.33333% удлинение конечности;
 - ~%50% невозможность производить движения в суставе;
 - ~%33.33333% крепитация.
- }

Абсолютные признаки перелома кости: {

- ~%50% деформация кости;
 - ~%50% выпячивание под кожей костных отломков;
 - ~%33.33333% локальная боль;
 - ~%33.33333% нарушение функции поврежденной конечности;
 - ~%33.33333% отек.
- }

Абсолютные признаки перелома кости: {

- ~%-25% отек;
 - ~%-25% нарушение функции поврежденной конечности;
 - ~%-25% локальная боль;
 - ~%33.33333% укорочение конечности;
 - ~%33.33333% патологическая подвижность в месте перелома;
 - ~%33.33333% крепитация;
 - ~%-25% удлинение конечности.
- }

Относительные признаки перелома кости: {

- ~%-33.33333% деформация кости;
 - ~%-33.33333% выпячивание под кожей костных отломков;
 - ~%50% локальная боль;
 - ~%-33.33333% крепитация в месте перелома;
 - ~%50% отек.
- }

Цели транспортной иммобилизации: {

- ~%-33.33333% остановка кровотечения;
 - ~%50% профилактика усиления боли;
 - ~%-33.33333% уменьшение боли;
 - ~%-33.33333% профилактика новых переломов этой кости;
 - ~%50% профилактика превращения закрытого перелома в открытый.
- }

Признаки закрытого перелома позвоночника: {

- ~%50% резкая боль в месте повреждения, усиливающаяся при надавливании на голову или остистый отросток в месте перелома;
 - ~%-33.33333% отек места перелома;
 - ~%50% рефлекторное напряжение мышц спины;
 - ~%-33.33333% крепитация отломков костей;
 - ~%-33.33333% вынужденное необычное положение конечности.
- }

Виды пневмоторакса: {

- ~%-25% наружный;
 - ~%33.33333% закрытый;
 - ~%33.33333% открытый;
 - ~%-25% внутренний;
 - ~%33.33333% клапанный;
 - ~%-25% прямой;
 - ~%-25% не прямой.
- }

При переломе ребра на грудную клетку накладывают ... повязку: {

- ~ асептическую;
 - ~ давящую;
 - ~ герметизирующую;
 - =циркулярную
 - ~ косыночную.
- }

Признаки закрытого перелома ребер: {

- ~%-33.33333% кровотечение;
 - ~%50% крепитация;
 - ~%50% отставание при дыхании поврежденной половины грудной клетки;
 - ~%-33.33333% мелкоочечные кровоизлияния на коже;
 - ~%-33.33333% тахикардия.
- }

Признаки закрытого перелома ребер: {

- ~%50% локальная боль, усиливающаяся при вдохе, кашле, наклоне туловища;
 - ~%50% крепитация;
 - ~%-33.33333% кровотечение;
 - ~%-33.33333% мелкоочечные кровоизлияния на коже;
 - ~%-33.33333% учащенное сердцебиение.
- }

Признаки тяжелого сотрясения головного мозга: {

- ~%-25% рвота;
 - ~%33.33333% ретроградная амнезия;
 - ~%-25% головная боль;
 - ~%33.33333% потеря сознания более суток;
 - ~%-25% кратковременная потеря сознания;
 - ~%33.33333% нарушение функций мозга;
 - ~%-25% одышка.
- }

Оказание первой доврачебной помощи при сотрясении головного мозга: {

- ~%50% транспортировка лежа на спине, голову повернуть на бок;
 - ~%-33.33333% тепло на голову;
 - ~%50% холод на голову;
 - ~%-33.33333% транспортировка лежа на спине, голову запрокинуть;
 - ~%-33.33333% транспортировка в полусидячем положении.
- }

Признаки сдавливания головного мозга: {

~%50% длительная потеря сознания, кома;
~%-33.33333%временная потеря сознания;
~%-33.33333%зрачки расширены;
~%50%разная величина зрачков;
~%-33.33333%зрачки сужены.
}

При тупой тяжелой травме живота запрещается: {
~%-33.33333%холод на живот;
~%50% тепло на живот;
~%50% давать обезболивающее в виде таблеток;
~%-33.33333%смачивать губы;
~%-33.33333%полоскать рот водой.
}

При тупой тяжелой травме живота запрещается: {
~%-33.33333%холод на живот;
~%50% тепло на живот;
~%-33.33333%смачивать губы водой;
~%50% поить;
~%-33.33333%полоскать рот водой.
}

Признаки перелома костей таза: {
~%50% «симптом пятки» – невозможность оторвать пятку от земли в положении лежа;
~%-33.33333%судороги;
~%-33.33333%тошнота, рвота;
~%50% боль;
~%-33.33333%головная боль.
}

Симптомы травматического шока стадии возбуждения: {
~%-33.33333%заторможенность;
~%50% возбуждение;
~%50% артериальное давление повышено;
~%-33.33333%артериальное давление снижено;
~%-33.33333%маскообразное выражение лица.
}

Симптомы травматического шока стадии торможения: {
~%50% заторможенность;
~%-33.33333%возбуждение;
~%-33.33333%артериальное давление повышено;
~%50% артериальное давление снижено;

~%-33.33333%пульс напряжен.
}

Первая помощь при травматическом шоке: {
~%33.33333%прием обезболивающего;
~%-25% прием снотворного;
~%-25% прием возбуждающих средств (кофеин);
~%33.33333%остановка кровотечения;
~%33.33333%транспортная иммобилизация при переломе;
~%-25% обильное питье с добавлением питьевой соды;
~%-25% искусственная вентиляция легких.
}

Первая помощь при травматическом токсикозе: {
~%-33.33333%наложить согревающий компресс;
~%50% наложить жгут выше места сдавления;
~%50% обильное питье с добавлением питьевой соды;
~%-33.33333%дать снотворное;
~%-33.33333%дать возбуждающие препараты.
}

Симптомы травматического токсикоза: {
~%-33.33333%кожа бледная;
~%50% мелкие кровоизлияния и пузыри, наполненные светлой или кровянистой жидкостью;
~%-33.33333%артериальное давление повышено;
~%50% уменьшение выделяемой мочи (олигурия) вплоть до полного ее отсутствия (анурия);
~%-33.33333%брадикардия.
}

Комбинированными травмами, полученными в транспортной аварии, являются: {
~%50% ушиб головного мозга и химический ожог кожи рук;
~%-33.33333%повреждения легких и кишечника;
~%-33.33333%черепно-мозговая травма и повреждение тазовых костей;
~%50% перелом голени в сочетании с термическим ожогом;
~%-33.33333%множественные переломы костей верхних конечностей.
}

Сочетанными травмами, полученными в транспортной аварии, являются: {
~%-33.33333%ушиб головного мозга и химический ожог кожи рук;
~%50% повреждения легких и кишечника;
~%50% черепно-мозговая травма и повреждение тазовых костей;
~%-33.33333%перелом голени в сочетании с термическим ожогом;

~%-33.33333%множественные переломы костей верхних конечностей.
}

Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей: {

~смазать обожженную поверхность маслом или жиром

~промыть под струей холодной воды в течении 10-15 мин. Забинтовать чистой повязкой.

=подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 20-30 мин.

~обработать обожженную поверхность спиртом и накрыть чистой салфеткой
}

Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей {

~промыть рану водой в течении 15 мин. забинтовать сухой стерильной повязкой.

~промыть рану водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

=накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

~промыть рану водой, обработать перекисью водорода
}

При ранениях глаз или век {

~%33.33333%накрыть глаза чистой салфеткой и зафиксировать ее повязкой.

~%-50%разрешается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век

~%-50%все операции проводить в положении пострадавшего «сидя»

~%33.33333%все операции проводить в положении пострадавшего «лежа»

~%33.33333%запрещается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век
}

Первая помощь при ожогах глаз или век в случаях попадания едких химических веществ {

=раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды.

Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи

~раздвинуть осторожно веки пальцами, нейтрализовать жидкость (уксус или сода) и подставить под струю холодной воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа наружу

~раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды.

Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от изнутри к носу

~раздвинуть осторожно веки пальцами и промыть теплой водой. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от изнутри к носу
}

Действия при переохлаждении {

~%33.33333%предложить теплое сладкое питье

~%-50%дать 50 мл алкоголя, даже если пострадавший находится в алкогольном опьянении, и доставить в теплое помещение

~%33.33333%снять одежду и поместить в ванну с температурой воды 35-40С

~%-50%давать повторные дозы алкоголя недопустимо

~%33.33333%после согревающей ванны укрыть теплым одеялом или надеть теплую одежду

}

Действия при обморожении{

~%33.33333%как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое помещение

~%33.33333%снять одежду и обувь

~%33.33333%укрыть одеялом или теплой одеждой

~%-50%поместить обмороженные конечности в теплую воду или обложить грелками

~%-50%наложить масло и растереть кожу

}

Действия в случае длительного сдавливания конечностей{

~%50%обложить конечности холодом

~%50%после освобождения от сдавливания туго забинтовать конечности

~%-50%согреть придавленные конечности

~%-50%не давать жидкости до прибытия врачей

}

Когда необходимо накладывать шины на конечности{

~%20%видны костные обломки

~%20%при жалобах на боль

~%20%при деформациях и отеках конечностей

~%20%после освобождения придавленных конечностей

~%20%при укусах ядовитых змей

~%-50%при подозрении на повреждение позвоночника

~%-50%в случаях синдрома сдавливания до освобождения конечностей

}

Когда пострадавшего необходимо переносить на щите с подложенным под колени валиком или на вакуум-носилках в позе «лягушки» {

~%33.33333%при подозрении на перелом костей таза

~%33.33333%при подозрении на перелом верхней трети бедренной кости и повреждение тазобедренного сустава

~%33.33333%при подозрении на повреждение позвоночника

~%-50%при ранениях шеи

~%-50%при проникающих ранениях живота

}

Когда пострадавших переносят только на животе{

~%25%в состоянии комы
~%25%при частой рвоте
~%25%в случаях ожога спины и ягодиц
~%25%при подозрении на повреждение спинного мозга. Когда в наличии есть только брезентовые носилки
~%-50%при проникающих ранениях брюшной полости
~%-50%при проникающих ранениях грудной клетки
}

Когда пострадавшего можно переносить только сидя или полусидя {
~%50%при проникающих ранениях грудной клетки
~%50%при ранениях шеи
~%-50%при проникающих ранениях брюшной полости
~%-50%при частой рвоте
}

Когда пострадавшего можно переносить только на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами {
~%50%при проникающих ранениях брюшной полости
~%50%при большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение
~%-50%при проникающих ранениях грудной клетки
~%-50%в состоянии комы
}

Признаки синдрома сдавливания нижних конечностей (появляются спустя 15 минут) {
~%25%после освобождения сдавленной конечности- резкое ухудшение состояния пострадавшего
~%25%появление отека конечности с исчезновением рельефа мышц
~%25%отсутствие пульса у лодыжек
~%25%появление розовой или красной мочи
~%-50%отсутствие пульса на сонной артерии
~%-50%синюшный цвет кожи
}

Признаки открытого перелома костей конечностей {
~%33.33333%видны костные обломки
~%33.33333%деформация и отек конечности
~%33.33333%наличие раны, часто с кровотечением
~%-50%синюшный цвет кожи
~%-50%сильная боль при движении
}

Признаки закрытого перелома костей конечности {

~%-50%видны костные обломки
~%33.33333%деформация и отек конечности
~%-50%наличие раны, часто с кровотечением
~33.33333%синюшный цвет кожи
~33.33333%сильная боль при движении
}

Признаки обморожения нижних конечностей {
~%25%потеря чувствительности
~%25%кожа бледная, твердая и холодная на ощупь
~%25%нет пульса у лодыжек
~%25%при постукивании пальцем — деревянный звук
~%-50%озноб и дрожь
~%-50%снижение температуры тела
}

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи {
~Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод
~Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод
=Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод
~Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод
~Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод
}

При переохлаждении пострадавшего находящегося в помещении необходимо поместить в ванну с температурой воды в пределах: {
~25 — 30 град.
~25 — 35 град.
~30 — 35 град.
=35 — 40 град.
~35 — 45 град.
}

При обморожении пострадавшему, находящемуся в помещении с укрытыми конечностями необходимая дальнейшая схема действия помощи: {
~дать 1-2 таблетки анальгина, дать обильное тёплое питьё, вызвать «Скорую помощь»
~дать 1-2 таблетки анальгина, дать обильное тёплое питьё, предложить малые дозы алкоголя, вызвать «Скорую помощь»
=дать обильное тёплое питьё, вызвать «Скорую помощь»
~дать обильное тёплое питьё, дать 1-2 таблетки анальгина, вызвать «Скорую помощь»

~дать обильное тёплое питьё, предложить малые дозы алкоголя, вызвать «Скорую помощь»
}

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами {

~ в состоянии комы

~ при частой рвоте

= при проникающих ранениях брюшной полости

~ при проникающих ранениях грудной клетки

~при ранении шеи

}

Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют подручные средства для их изготовления? {

~ Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают.

~ Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань.

= Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив между ними мягкую ткань.

~ сгибают в коленных суставах и прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань.

}

О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь необходимо при этом оказать? {

~ У пострадавшего могут быть переломы костей голени и нижней трети бедра. При первой помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного сустава, не вытягивая ногу.

~ У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного сустава до подмышки.

=У пострадавшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под колени валик из мягкой ткани, к животу по возможности приложить холод.

~ У пострадавшего могут переломы шейки бедра, может быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного сустава до подмышки

}

В какой последовательности следует осматривать ребенка при его травмировании? {

~ конечности, область таза и живот, грудная клетка, шея, голова
= голова, шея, грудная клетка, живот и область таза, конечности
~ грудная клетка, живот и область таза, голова, шея, конечности
~ конечности, голова, шея, область таза, живот, грудная клетка
}

В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при повреждении позвоночника? {

~ Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги
= Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела
~ Уложить пострадавшего на бок
~ Уложить пострадавшего на живот
}

Перелом это {

= трещины, сколы, раздробление костей
~ разрушение мягких тканей костей
~ трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела
~ трещины с разрушением окружающих мягких тканей
}

Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в дыхательные пути: {

~ Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту.
= Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных ударов ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта — обхватить пострадавшего сзади, надавить 4-5 раз на верхнюю часть живота.
~ Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов ладонью между лопаток.
~ положить пострадавшего на спину, нанести несколько интенсивных ударов кулаком в область грудины
}

Первая медицинская помощь при вывихе конечности? {

~ Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с горячей водой, организовать транспортировку в больницу или травмпункт
= Осуществить иммобилизацию конечности, дать доступные обезболивающие средства, приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной водой или льдом, организовать транспортировку в больницу или травмпункт

~ Дать обезболивающее средство, вправить вывих и зафиксировать конечность
~ Дать обезболивающее средство, организовать транспортировку в больницу или
травмпункт
}

Основные правила оказания первой помощи при травматическом шоке: {
= Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов.
Восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности, временная
остановка кровотечения, борьба с болью, закрытие ран стерильными (чистыми)
повязками, придание пострадавшему наиболее удобного положения, обеспечить
приток свежего воздуха, организовать вызов к месту происшествия скорой
медицинской помощи.
~ Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов.
Снять одежду или ослабить ее давление. Дать понюхать нашатырный спирт.
Наложить на лоб холодный компресс. Обеспечить приток свежего воздуха.
Организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской помощи.
~ Уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт.
Наложить теплые примочки на лоб и затылок.
~ уложить пострадавшего на спину, поднять ножной конец. Дать понюхать
нашатырный спирт, дать обезболивающее
}

При переломах костей конечностей накладывается шина: {
~ ниже области перелома
= выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух
ближайших суставов
~ выше области перелома
~ при переломах конечностей шина не накладывается
}

При черепно-мозговой травме: {
~ необходимо положить на голову тепло
= необходимо положить на голову холод
~ необходимо наложить на голову марлевую повязку
~ необходимо наложить на голову тугую повязку
}

Пострадавшему с травмой груди следует придать следующее положение: {
~ положение на спине с приподнятыми ногами;
~ устойчивое боковое положение;
= полусидячее положение с наклоном в пораженную сторону;
~ положение на спине с полусогнутыми и разведенными ногами;
~ положение на животе.
}

Укажите, в каких случаях осуществляется экстренное извлечение пострадавшего из аварийного автомобиля: {

~ во всех случаях, когда пострадавшему требуется немедленное оказание первой помощи;

~ экстренное извлечение пострадавшего производится только силами сотрудников скорой медицинской помощи или спасателями МЧС;

= наличие угрозы для жизни и здоровья пострадавшего и невозможность оказания первой помощи в автомобиле;

~ в случае, если у пострадавшего отсутствуют признаки серьезных травм.

}

Целью придания пострадавшему оптимального положения его тела является: {

~ повышение удобства для человека, оказывающего первую помощь;

~ обеспечение доступа для наложения повязок, кровоостанавливающих жгутов и т. д.;

= придание пострадавшему удобного положения, обеспечивающего ему комфорт, уменьшающего степень его страданий и не усугубляющего нарушения жизненно важных функций;

~ предупреждение или снижение риска самопроизвольного перемещения тела пострадавшего.

}

Какую помощь следует оказать пострадавшему с предположительным переломом костей голени в случае, если травма получена в населенном пункте: {

~ зафиксировать голень подручными средствами, вызвать скорую медицинскую помощь;

= помочь пострадавшему принять удобное положение, вызвать скорую медицинскую помощь, приложить холод к месту предполагаемого перелома;

~ зафиксировать голень транспортными шинами, приложить холод, доставить пострадавшего в травмпункт;

~ зафиксировать голень транспортными шинами, дать обезболивающее средство, вызвать скорую медицинскую помощь, приложить холод к месту предполагаемого перелома.

}

Придание устойчивого бокового положения пострадавшему следует начать: {

= с расположения одной руки пострадавшего под углом к его телу;

~ с поворота нижней части его тела на бок;

~ с расположения руки пострадавшего тыльной стороной ладони к его щеке;

~ с расстегивания стягивающей одежды.

}

Выбор способа переноски пострадавшего при оказании первой помощи зависит:

~ от наличия средств переноски (носилок, строп) пострадавших;

~ от предполагаемой дальности переноски;

~ от желания пострадавшего;
= от количества участников оказания первой помощи, их физических возможностей и характера травм.
}

Переноску в одиночку на плече желательно не применять в отношении пострадавших с нижеприведенными травмами и состояниями: {

~ травмы конечностей;
~ травма головы;
= травмы груди и живота;
~ ожоги и отморожения;
~ отравления.
}

Переноску в одиночку волоком не рекомендуется применять для пострадавших со следующими травмами: {

~ травмы грудной клетки;
~ травмы живота;
~ травмы головы;
= травмы нижних конечностей.
}

Какое положение лучше занять пострадавшему с травмой груди? {

~ лежа, с приподнятыми ногами;
= полусидя;
~ стоя у опоры;
~ лежа на левом боку.
}

Транспортировать пострадавшего самостоятельно необходимо: {

~ всегда, если он сам не может передвигаться;
~ если у пострадавшего угрожающее жизни состояние;
= если нет возможности вызвать скорую медицинскую помощь;
~ во всех перечисленных случаях.
}

После того как вы произвели наложение кровоостанавливающего жгута, травмированную конечность необходимо: {

~ укутать;
= обездвижить и укутать;
~ приподнять, обездвижить и укутать;
~ обездвижить.
}

Какое положение необходимо придать пострадавшему с подозрением на травму живота: {

- ~ полусидячее с наклоном в поврежденную сторону;
- = лежа на спине с согнутыми в коленях и разведенными ногами;
- ~ лежа на менее травмированном боку;
- ~ лежа на боку с поджатыми ногами.

}

Какое положение необходимо придать пострадавшему с подозрением на травму грудной клетки? {

- = полусидячее с наклоном в поврежденную сторону;
- ~ лежа на спине с приподнятыми ногами;
- ~ лежа на менее травмированном боку;
- ~ лежа на боку с приведенными к туловищу ногами.

}

При иммобилизации нижней конечности, перед тем как накладывать шину, необходимо: {

- ~ вернуть конечность в естественное положение;
- ~ снять обувь;
- = обувь не снимать, конечность без необходимости не трогать, не пытаться вернуть в нормальное положение;
- ~ вернуть конечность в нормальное положение, снять обувь.

}

Ногу пострадавшего придавило обрушившейся конструкцией. Что вы сделаете, прежде чем извлечь его из-под завала? {

- ~ будучи уверенным в отсутствии опасности, постараетесь самостоятельно извлечь пострадавшего;
- ~ вызовете экстренные службы, позовете на помощь и, убедившись в отсутствии опасности, постараетесь извлечь пострадавшего;
- = вызовете экстренные службы, позовете на помощь, затем, убедившись в отсутствии опасности, наложите жгут на конечность и попытаетесь самостоятельно извлечь пострадавшего;
- ~ вызовете экстренные службы и будете ожидать их прибытия.

}

Первая помощь пострадавшему с травмой живота, сопровождающейся выпадением внутренних органов, заключается в следующем: {

- ~ пытаться вправить выпавшие органы;
- ~ оставлять выпавшие органы снаружи;
- = накрывать выпавшие органы влажной, чистой тканью;
- ~ приложить холод к выпавшим органам.

}

Перемещение пострадавшего с подозрением на травму позвоночника следует выполнять следующим способом: {

- ~ на руках с привлечением нескольких человек;
 - ~ на твердой ровной поверхности (щит);
 - = любым из перечисленных способов;
 - ~ ни одним из перечисленных способов.
- }

Пострадавший в ДТП человек получил следующие повреждения: ссадины на лице, многочисленные кровоподтеки по всему телу. В области бедра одежда разорвана, имеется кровотечение обильной струей темно-вишневого цвета.

Он находится на проезжей части. Что является приоритетным действием в этой ситуации: {

- = обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи (перемещение пострадавшего, выставление знаков аварийной остановки и т. п.);
 - ~ остановка кровотечения путем прямого давления на рану и наложение давящей повязки;
 - ~ обработка ссадин антисептическим раствором;
 - ~ вызов скорой медицинской помощи;
 - ~ придание пострадавшему оптимального положения тела.
- }

Автомобиль, попавший в ДТП, несколько раз перевернулся. В результате пострадал водитель автомобиля. Есть необходимость в его экстренном извлечении вследствие риска возгорания автомобиля. О чем следует помнить в первую очередь: {

- ~ извлекать пострадавшего необходимо очень бережно;
 - = при извлечении необходимо обязательно фиксировать голову и шею;
 - ~ извлечение следует выполнить как можно быстрее для снижения риска дополнительного повреждения пострадавшего пламенем;
 - ~ пострадавшего не следует извлекать, постараться устранить опасность возгорания своими силами.
- }

Можно ли вправить вывих пострадавшему при оказании первой помощи: {

- ~ можно, если пострадавший не ощущает боль.
 - ~ можно, если отек еще не наступил.
 - ~ можно, если об этом попросил пострадавший
 - = нельзя, ни при каких обстоятельствах
- }

В качестве шины для иммобилизации конечности целесообразно использовать следующие предметы: {

- = доски, палки, зонт.

- ~ бинт, платок, простыня.
- ~ трава, вода, мазь.
- ~ ремень, пояс, галстук

}

Транспортировка пострадавших сидя осуществляется при: {

- ~ повреждении верхних конечностей и органов брюшной полости.

= переломе ключицы, перелом ребер.

- ~ повреждении органов брюшной полости
- ~ повреждение костей черепа и лица

}

Транспортировку пострадавшего с черепно-мозговой травмой необходимо осуществлять: {

- = лежа на боку
- ~ лежа на спине
- ~ сидя
- ~ стоя

}

При ушибе в рамках оказания первой помощи надо: {

- = наложить холодный компресс, обеспечить ушибленному органу покой.
- ~ наложить согревающий компресс.
- ~ осторожно растереть травмированный участок, наложить повязку.
- ~ наложить жгут, обеспечить ушибленному органу покой

}

При повреждении связок в рамках оказания первой помощи надо: {

- ~ согреть поврежденный сустав, обеспечить покой.

= наложить повязку, фиксирующую сустав, прикладывать холодный компресс.

- ~ интенсивно растереть, наложить тугую повязку.
- ~ осторожно растереть травмированный участок

}

При переломах конечностей у пострадавшего и отсутствия транспортных шин и подручных средств, для их изготовления можно: {

- ~ верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу, а нижние конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань.

= верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу, а нижние конечности прибинтовывают друг к другу не выпрямляя, проложив между ними мягкую ткань.

- ~ верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу, а нижние конечности выпрямляют и плотно прижимают друг к другу

~ верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу, а нижние конечности выпрямляют и плотно прижимают друг к другу
}

Иммобилизация – это ... {

~ запрещение передвижения в опасной зоне
= обездвиживание пострадавшей части тела
~ перенесение пострадавшего в безопасное место
~ влияние излучения приборов на пострадавшего
}

Перелом позвоночника фиксируют: {

~ тремя шинами;
= укладывают пострадавшего на твердый щит;
~ накладывают тугую бинтовую повязку.
~ укладывают пострадавшего на бок.
}

При переломе костей таза проводят иммобилизацию путем: {

~ наложения двух шин;
~ укладывают больного на твердый щит;
= укладывают больного на твердый щит и под коленные суставы подкладывают упругий валик.
~ наложения трех шин
}

При вывихе плеча: {

~ накладывают шину, не меняя положения плеча;
~ вправляют вывих;
= прибинтовывают плечо к туловищу.
~ прибинтовывают кисть к туловищу
}

Тяжелую травму, как правило, сопровождает общая реакция организма {

~ повышенная раздражительность
~ слабость
~ депрессия
~ апатия
= шок
}

При наложении шины в случае перелома кости бедра обездвиживают суставы: {

~%33.33333% голеностопный
~%33.33333% тазобедренный
~%33.33333% коленный

~%-50% тазовокрестцовый
~%-50% поясничной части позвоночника
}

При оказании первой помощи пострадавшему с травмой конечности, в ране которого – торчащий обломок стекла, необходимо: {

~ срочное извлечение обломка
~ принятие мер по обездвиживанию пораженной конечности
= наложение повязки из чистой ткани поверх обломка
~ дать пострадавшему обезболивающее лекарство
~ наложение повязки из чистой ткани после извлечения обломка
~ смазывание краев раны жировым веществом
}

Правильная транспортировка пострадавшего, находящегося без сознания производится: {

~ в положении на спине.
= в положении на животе (при травмах брюшной полости – на боку)
~ с приподнятыми нижними конечностями.
~ в полусидячем положении
}

Что необходимо сделать перед началом транспортировки пострадавших? {

~ дать пострадавшему обезболивающее средство, чтобы при транспортировке он не впал в кому
~ проверить состояние пострадавшего, насколько он готов к транспортировке
= оказать первую помощь в соответствующем объеме и провести иммобилизацию поврежденных частей тела, если они имеются
~ придать пострадавшему оптимальное положение
}

Как оказать первую помощь при открытом переломе конечности? {

~ туго перебинтовать поврежденную конечность.
~ совместить костные отломки друг с другом, наложить повязку, зафиксировать конечность с помощью шины
= наложить повязку на рану, зафиксировать конечность с помощью шины.
~ наложить давящую повязку
}

Какие симптомы наблюдаются при сотрясении головного мозга? {

~ похолодание тела, потеря сознания.
= головная боль, тошнота, слабость, потеря сознания.
~ деформация черепа, очковая гематома.
~ тошнота, судороги
}

Назовите симптомы вывиха: {

~ боль в конечности, общая слабость.

= боль в конечности, деформация области сустава, отсутствие движения в суставе.

~ резкая боль, отек, патологическая подвижность

~ общая слабость, боль

}

В каких случаях пострадавшего извлекают из салона автомобиля? {

~ всегда при потере потерпевшим сознания.

= при потере потерпевшим сознания и отсутствии у него пульса на сонной артерии и признаков дыхания.

~ при переломах нижних конечностей.

~ при артериальном кровотечении

}

Каков порядок оказания помощи в случаях падения с высоты при сохранении сознания? {

~%25% оценить состояние пострадавшего;

~%25% переложить пострадавшего на ковшовые носилки;

~%25% переложить пострадавшего на вакуумный матрас;

~%25% зафиксировать пострадавшего на вакуумном матрасе в позе «лягушки».

~%-100% посадить пострадавшего

}

Действия в случае длительного сдавливания конечностей: {

~%50% обложить конечности холодом

~%50% после освобождения от сдавливания туго забинтовать конечности

~%-50% согреть придавленные конечности

~%-50% не давать жидкости до прибытия врачей

}

В каком состоянии пострадавших переносят только на животе: {

~%25% в состоянии комы

~%25% при частой рвоте

~%25% в случаях ожога спины и ягодиц

~%25% при подозрении на повреждение спинного мозга, когда в наличии есть только

~%-50% при проникающих ранениях брюшной полости

~%-50% при проникающих ранениях грудной клетки

}

Укажите, в каком положении госпитализируют пострадавших при успешной реанимации после утопления: {

= лежа на боку с опущенным подголовником носилок

- ~ лежа на боку с приподнятым подголовником носилок
- ~ лежа на спине на жестких (щитовых) носилках
- ~ положение пострадавшего на носилках не имеет значения

Клинические признаки, встречающиеся при любом виде травм: {

- ~ боль, деформация, патологическая подвижность
- = боль, гематома, отек
- ~ боль, гематома, ограничение движений
- ~ боль, гематома, патологическая подвижность

Ушиб – это ... {

- = механическое повреждение тканей без видимого нарушения их целостности
- ~ механическое повреждение тканей с видимым нарушением их целостности
- ~ любое механическое повреждение тканей
- ~ любое механическое или иное повреждение тканей

В качестве первой помощи при ушибах чаще всего применяется: {

- = холод к месту ушиба
- ~ тугие повязки на место ушиба
- ~ иммобилизация места ушиба
- ~ растирание обезболивающими мазями

Вывих – это ... {

- = стойкое смещение суставных концов сочленяющихся костей
- ~ нестойкое (легко устранимое) смещение суставных концов сочленяющихся костей
- ~ периодически возникающее смещение суставных концов сочленяющихся костей
- ~ нарушение целостности суставных концов сочленяющихся костей

Укажите клинические признаки вывиха: {

- ~%33.33333% боль, гематома, отек
- ~%33.33333% изменение конфигурации пораженного сустава
- ~%33.33333% резкое ограничение или полное отсутствие движений в пораженном суставе
- ~%-100% патологическая подвижность

Перелом – это ... {

- ~ полное нарушение целостности кости

- ~ частичное нарушение целостности кости
- = полное или частичное нарушение целостности кости
- ~ нарушение целостности кости с обязательным повреждением надкостницы
- }

Укажите признаки перелома: {

- ~%33.33333% боль, гематома, отек
- ~%33.33333% деформация в области перелома
- ~%33.33333% при повреждении конечности – нарушение функции конечности
- ~%-100% при повреждении конечности – нарушение функции конечности только в случаях повреждения в области сустава
- }

Основной признак перелома – это ... {

- = усиление боли при осевой нагрузке на сломанную кость
- ~ ослабление боли при осевой нагрузке на сломанную кость
- ~ крепитация костных отломков при движении
- ~ патологическая подвижность
- }

Выберите правильную последовательность действий при оказании доврачебной помощи пострадавшему при подозрении на перелом: {

- ~ шинирование, холод на область перелома, обезболивание
- ~ обезболивание, холод на область перелома, шинирование
- = обезболивание, шинирование, холод на область перелома
- ~ холод на область перелома, шинирование, обезболивание
- }

Укажите правильную последовательность действий при оказании помощи пострадавшему с открытым переломом лучевой кости (повреждения лучевой артерии нет): {

- = обезболивание, повязка на рану, шинирование, холод на область перелома, транспортировка в лечебное учреждение
- ~ шинирование, повязка на рану, холод на область перелома, обезболивание, транспортировка в лечебное учреждение
- ~ повязка на рану, шинирование, холод на область перелома, обезболивание, транспортировка в лечебное учреждение
- ~ холод на область перелома, повязка на рану, шинирование, обезболивание, транспортировка в лечебное учреждение
- }

Если при открытом переломе имеется повреждение артерии, то кровоостанавливающий жгут накладывается: {

- = в первую очередь
- ~ после проведения обезболивания для избежания травматического шока

- ~ после применения холода для уменьшения кровопотери
- ~ в порядке, обусловленном силой кровотока

}

При подозрении на повреждение ключицы возможно проведение иммобилизации:

{

- ~%50% ватно-марлевыми кольцами Дельбе
- ~%50% повязкой типа Дезо
- ~%50% 8-образной повязкой
- ~%50% шиной Еланского

}

При наложении шины при повреждениях кисти необходимо: {

- ~%50% положить валик под ладонь
- ~%50%плотно прификсировать ладонь к шине
- ~%50% противопоставить 1 палец, если он не поврежден
- ~%50% если 1 палец поврежден, то фиксировать его вместе со всей кистью

}

Черепно-мозговая травма – это ... {

- = механическое повреждение костей черепа и головного мозга
- ~ повреждение только головного мозга
- ~ механическое повреждение костей черепа
- ~ ранение мягких тканей черепа без повреждения костей

}

Укажите основной признак черепно-мозговой травмы: {

- ~ головные боли и головокружение
- = потеря больным сознания в момент травмы
- ~ тошнота, рвота после травмы
- ~ вялость, сонливость

}

Синдром длительного сдавления развивается примерно через ... {

- = 40 минут непрерывного сдавления
- ~ не ранее чем, через 1,5-2 часа непрерывного сдавления
- ~ 10-15 минут непрерывного сдавления
- ~ более чем, через 2 часа после непрерывного сдавления

}

Углублению травматического шока способствует ... {

- ~%33.33333% кровопотеря
- ~%33.33333% неправильная иммобилизация
- ~%33.33333% травматичная транспортировка
- ~%100% обезболивание

}

Оказание ПП при травматическом шоке на догоспитальном этапе складывается из основных пунктов: {

~%33.33333% при нарушениях дыхания и остановке сердца – сердечно-легочная реанимация

~%33.33333% остановка наружного кровотечения

~%33.33333% обезболивание, правильная иммобилизация

~%-100% борьба с гиповолемией (введение полиглюкина, реополиглюкина и т.д.)

}

Признаки травмы органов брюшной полости: {

= сильная боль, болезненность или чувство сдавленности в животе, появление синяков, рвота (иногда с кровью или черного цвета), слабость, кровь в кале (черный кал).

~ сильная боль, болезненность или чувство сдавленности в животе, появление синяков, рвота (иногда с кровью), слабость, кровь в кале (черный кал).

~ сильная боль, болезненность или чувство сдавленности в животе, появление синяков, рвота (черного цвета), слабость, кровь в кале (черный кал).

~ сильная боль, болезненность или чувство сдавленности в животе, появление синяков, рвота, слабость, кровь в кале.

~ сильная боль, болезненность или чувство сдавленности в животе, появление синяков, рвота (иногда с кровью или черного цвета), слабость, кровь в кале (кал со слизью).

}

Признаки закрытого повреждения живота, сопровождающееся внутрибрюшным кровотечением: {

= бледность, холодный пот, жалобы на головокружение, головокружение усиливается при вертикальном положении тела, пульс частый, одышка.

~ бледность, холодный пот, жалобы на головокружение.

~ жалобы на головокружение, головокружение усиливается при вертикальном положении тела.

~ бледность, холодный пот, жалобы на головокружение, головокружение усиливается при вертикальном положении тела, пульс частый.

~ бледность, холодный пот, жалобы на головокружение, головокружение усиливается при вертикальном положении тела, одышка.

}

Признаки закрытого повреждения живота, сопровождающегося разрывом полого органа: {

~ бледность, выражение лица напряженное, живот напряжен, пульс частый, дыхание учащено.

~ бледность, выражение лица напряженное, любое движение приводит к усилению болей, пульс частый, дыхание учащено.

= бледность, выражение лица напряженное, любое движение приводит к усилению болей, живот напряжен, пульс частый, дыхание учащено.

~ бледность, выражение лица напряженное, любое движение приводит к усилению болей, живот напряжен, дыхание учащено.

~ бледность, выражение лица напряженное, любое движение приводит к усилению болей, живот напряжен, пульс частый.

}

Первая помощь при травматическом шоке: {

= накрыть пострадавшего одеялом или пальто, попросить его занять положение лежа (голова на одном уровне с телом), поднять ноги на 30 см выше уровня тела, чтобы улучшить приток крови к жизненно важным органам (не поднимать ноги при травме головы, шеи, позвоночника, бедра или голени, подозрении на сердечный приступ, инсульт), не давать питье (можно смачивать губы водой, если он испытывает жажду).

~ накрыть пострадавшего одеялом или пальто, попросить его занять положение лежа (голова на одном уровне с телом), поднять ноги на 30 см выше уровня тела, чтобы улучшить приток крови к жизненно важным органам (не поднимать ноги при травме позвоночника, бедра или голени, подозрении на сердечный приступ, инсульт), не давать питье (можно смачивать губы водой, если он испытывает жажду).

~ накрыть пострадавшего одеялом или пальто, попросить его занять положение лежа (голова на одном уровне с телом), поднять ноги на 30 см выше уровня тела, чтобы улучшить приток крови к жизненно важным органам (не поднимать ноги при травме головы, шеи, позвоночника, бедра или голени, подозрении на сердечный приступ, инсульт), не давать питье.

~ накрыть пострадавшего одеялом или пальто, попросить его занять положение лежа (голова на одном уровне с телом), поднять ноги на 30 см выше уровня тела, чтобы улучшить приток крови к жизненно важным органам (не поднимать ноги при травме головы, шеи, позвоночника, подозрении на сердечный приступ, инсульт), не давать питье (можно смачивать губы водой, если он испытывает жажду).

~ накрыть пострадавшего одеялом или пальто, попросить его занять положение лежа (голова на одном уровне с телом), поднять ноги на 30 см выше уровня тела, чтобы улучшить приток крови к жизненно важным органам (не поднимать ноги при травме головы, шеи, позвоночника, бедра или голени, подозрении на сердечный приступ), не давать питье (можно смачивать губы водой, если он испытывает жажду).

}

Правила наложения шины: {

~ накладывается без изменения положения поврежденной части, шина должна охватывать как область повреждения, так и суставы, расположенные выше и ниже этой области, до и после наложения шины проверить кровообращение в поврежденной части тела(спросить пострадавшего, немеют ли у него кончики пальцев поврежденной конечности, проверить пальцы поврежденной конечности

(должны быть теплые на ощупь и иметь розовый цвет у ногтей), при жалобах на онемение ослабить повязку, зафиксировать шину выше и ниже области повреждения.

~ накладывается без изменения положения поврежденной части, шина должна охватывать как область повреждения, так и суставы, расположенные выше и ниже этой области, до и после наложения шины проверить кровообращение в поврежденной части тела(спросить пострадавшего, немеют ли у него кончики пальцев поврежденной конечности, проверить пальцы поврежденной конечности (должны быть теплые на ощупь и иметь розовый цвет у ногтей), при жалобах на онемение ослабить повязку, зафиксировать шину выше и ниже области повреждения.

~ накладывается без изменения положения поврежденной части, шина должна охватывать как область повреждения, так и суставы, расположенные выше и ниже этой области, до и после наложения шины проверить кровообращение в поврежденной части тела(спросить пострадавшего, немеют ли у него кончики пальцев поврежденной конечности, проверить пальцы поврежденной конечности (должны быть теплые на ощупь и иметь розовый цвет у ногтей), при жалобах на онемение ослабить повязку, зафиксировать шину выше и ниже области повреждения.

= накладывается без изменения положения поврежденной части, шина должна охватывать как область повреждения, так и суставы, расположенные выше и ниже этой области, до и после наложения шины проверить кровообращение в поврежденной части тела(спросить пострадавшего, немеют ли у него кончики пальцев поврежденной конечности, проверить пальцы поврежденной конечности (должны быть теплые на ощупь и иметь розовый цвет у ногтей), при жалобах на онемение ослабить повязку, зафиксировать шину выше и ниже области повреждения.

~ накладывается без изменения положения поврежденной части, шина должна охватывать как область повреждения, так и суставы, расположенные выше и ниже этой области, до и после наложения шины проверить кровообращение в поврежденной части тела(спросить пострадавшего, немеют ли у него кончики пальцев поврежденной конечности, проверить пальцы поврежденной конечности (должны быть теплые на ощупь и иметь розовый цвет у ногтей), при жалобах на онемение ослабить повязку, зафиксировать шину выше и ниже области повреждения.

}

Признаки закрытого перелома: {

~ отсутствие раны в зоне перелома, нарушение прямолинейности.

= отсутствие раны в зоне перелома, нарушение прямолинейности и появление ступеньки в месте перелома, подвижность, боль, припухлость.

~ отсутствие раны в зоне перелома, нарушение прямолинейности и появление ступеньки в месте перелома.

~ отсутствие раны в зоне перелома, нарушение прямолинейности и появление ступеньки в месте перелома, подвижность.

~ отсутствие раны в зоне перелома, нарушение прямолинейности и появление ступеньки в месте перелома, подвижность, боль.
}

Первая помощь при повреждении черепа, если пострадавший находится в бессознательном состоянии: {

= пострадавшего надо уложить на спину на носилки в положении полуоборота, под одну из сторон туловища подложить валик из верхней одежды, голову повернуть в левую сторону, чтобы в случае возникновения рвоты рвотные массы не попали в дыхательные пути, а вытекли наружу, расстегнуть стягивающую одежду, если у пострадавшего имеются зубные протезы и очки, то снять их, при острых нарушениях дыхания произвести искусственное дыхание.

~ пострадавшего надо уложить на спину на носилки в положении полуоборота без подушки, под одну из сторон туловища подложить валик из верхней одежды, голову повернуть в левую сторону, чтобы в случае возникновения рвоты рвотные массы не попали в дыхательные пути, а вытекли наружу, расстегнуть стягивающую одежду, если у пострадавшего имеются зубные протезы и очки, то снять их, при острых нарушениях дыхания произвести искусственное дыхание.

~ пострадавшего надо уложить на спину на носилки в положении полуоборота, под одну из сторон туловища подложить валик из верхней одежды, голову повернуть в правую сторону, чтобы в случае возникновения рвоты рвотные массы не попали в дыхательные пути, а вытекли наружу, расстегнуть стягивающую одежду, если у пострадавшего имеются зубные протезы и очки, то снять их, при острых нарушениях дыхания произвести искусственное дыхание.

~ пострадавшего надо уложить на спину на носилки в положении полуоборота, под одну из сторон туловища подложить валик из верхней одежды, голову повернуть в левую сторону и подложить под нее подушку, расстегнуть стягивающую одежду, если у пострадавшего имеются зубные протезы и очки, то снять их, при острых нарушениях дыхания произвести искусственное дыхание.

~ пострадавшего надо уложить на спину на носилки в положении полуоборота, под одну из сторон туловища подложить валик из верхней одежды, голову повернуть в левую сторону, чтобы в случае возникновения рвоты рвотные массы не попали в дыхательные пути, а вытекли наружу, расстегнуть стягивающую одежду, при острых нарушениях дыхания произвести искусственное дыхание.
}

Первая помощь при травматическом вывихе: {

~ при вывихе в плечевом зафиксировать верхнюю конечность бинтом к туловищу при вывихе суставов нижней конечности зафиксировать бинтом поврежденную ногу к здоровой ноге или к подручным средствам, придав больному суставу неподвижность, применить холод.

~ при вывихе локтевом суставе верхнюю конечность бинтом подвесить руку на косынке, при вывихе суставов нижней конечности зафиксировать бинтом поврежденную ногу к здоровой ноге или к подручным средствам, придав больному суставу неподвижность, применить холод.

= при вывихе в плечевом или локтевом суставе зафиксировать верхнюю конечность бинтом к туловищу или подвесить руку на косынке, при вывихе суставов нижней конечности зафиксировать бинтом поврежденную ногу к здоровой ноге или к подручным средствам, придав больному суставу неподвижность, применить холод.

~ при вывихе в плечевом или локтевом суставе зафиксировать верхнюю конечность бинтом к туловищу или подвесить руку на косынке, при вывихе суставов нижней конечности зафиксировать бинтом поврежденную ногу к здоровой ноге или к подручным средствам, применить холод.

~ при вывихе в плечевом или локтевом суставе зафиксировать верхнюю конечность бинтом к туловищу или подвесить руку на косынке, при вывихе суставов нижней конечности зафиксировать бинтом поврежденную ногу к здоровой ноге или к подручным средствам, придав больному суставу неподвижность.

}

Первая помощь при закрытых повреждениях живота и его полости: {

= пострадавшего уложить на носилки на спину, при внутрибрюшном кровотечении дать холод на живот.

~ пострадавшего уложить на носилки на левую сторону, при внутрибрюшном кровотечении дать холод на живот.

~ пострадавшего уложить на носилки на правую сторону, при внутрибрюшном кровотечении дать холод на живот.

~ пострадавшего уложить на носилки на живот при внутрибрюшном кровотечении дать холод на живот.

}

Переломы бывают: {

~ позвоночника.

~ ключицы и шейных позвонков.

~ конечностей.

= открытые и закрытые.

~ грудной клетки.

}

Первая помощь при повреждениях грудных и поясничных позвонков: {

~ повернуть пострадавшего на спину, связать руки на груди за запястья, связать ноги в области коленных суставов и лодыжек, у головы пострадавшего установить носилки, на которые на уровне поясницы положить валик из полотенца или одежды, обратив внимание на то, чтобы не было прогиба в области спины, приподнять пострадавшего уложить его на носилки.

~ повернуть пострадавшего на спину, связать ноги в области коленных суставов и лодыжек, у головы пострадавшего установить носилки, на которые на уровне поясницы положить валик из полотенца или одежды, обратив внимание на то, чтобы не было прогиба в области спины, приподнять пострадавшего, передвинуть

носилки под пострадавшего и опустить его на носилки.

= повернуть пострадавшего на спину, связать руки на груди за запястья, связать ноги в области коленных суставов и лодыжек, у головы пострадавшего установить носилки, на которые на уровне поясницы положить валик из полотенца или одежды, обратив внимание на то, чтобы не было прогиба в области спины, приподнять пострадавшего, передвинуть носилки под пострадавшего и опустить его на носилки.

~ повернуть пострадавшего на спину, связать руки на груди за запястья, у головы пострадавшего установить носилки, на которые на уровне поясницы положить валик из полотенца или одежды, обратив внимание на то, чтобы не было прогиба в области спины, приподнять пострадавшего, передвинуть носилки под пострадавшего и опустить его на носилки.

~ повернуть пострадавшего на спину, связать ноги в области коленных суставов и лодыжек, у головы пострадавшего установить носилки, на которые на уровне поясницы положить валик из полотенца или одежды, обратив внимание на то, чтобы не было прогиба в области спины, приподнять пострадавшего, передвинуть носилки под пострадавшего и опустить его на носилки.

}

Признаки перелома свода черепа: {

= гематома в области волосяного покрова части головы, рана при открытом повреждении, нарушение сознания и дыхания, другие изменения, выявленные при ощупывании.

~ гематома в области волосяного покрова части головы.

~ гематома в области волосяного покрова части головы, рана при открытом повреждении.

~ гематома в области волосяного покрова части головы, рана при открытом повреждении, нарушение сознания.

~ гематома в области волосяного покрова части головы, рана при открытом повреждении, нарушение сознания и дыхания.

}

Признаки травматического шока: {

~ бледная, холодная и влажная кожа, слабость, беспокойство, сухость во рту, жажда.

~ бледная, холодная и влажная кожа, слабость, беспокойство, сухость во рту, жажда, слабый учащенный пульс.

~ бледная, холодная и влажная кожа, слабость, беспокойство, сухость во рту, жажда, слабый учащенный пульс, учащенное дыхание, бессознательное состояние.

= бледная, холодная и влажная кожа, слабость, беспокойство, сухость во рту, жажда, слабый учащенный пульс, учащенное дыхание, спутанность сознания, бессознательное состояние.

~ бледная, холодная и влажная кожа, слабость, сухость во рту, жажда, слабый учащенный пульс, учащенное дыхание, спутанность сознания, бессознательное состояние.

}

Признаки перелома нижней челюсти: {

~ жалобы на боль в месте повреждения, усиливающуюся при речи.

= жалобы на боль в месте повреждения, усиливающуюся при речи и открывании рта, невозможность сомкнуть зубы, возможна кратковременная потеря сознания.

~ жалобы на боль в месте повреждения, усиливающуюся при речи и открывании рта, невозможность сомкнуть зубы.

~ жалобы на боль в месте повреждения, усиливающуюся при речи и открывании рта, невозможность сомкнуть зубы, возможно впадение в кому.

~ жалобы на боль, усиливающуюся при речи и открывании рта, невозможность сомкнуть зубы, возможна кратковременная потеря сознания.

}

Политравма — это: {

~ Повреждение одного органа или одного сегмента конечности.

= Собирательное понятие: повреждение двух и более различных областей тела, органов, сегментов конечностей, вызванных воздействием двух и более поражающих факторов.

~ Способ транспортировки пострадавшего.

~ повреждение одного сегмента конечности

}

Укажите простейшие приемы обезболивания при оказании первой помощи. {

~ «Холод» на область травмы.

~ Иммобилизация.

~ Физиологически выгодное(удобное) положение.

= Все перечисленное.

}

Укажите причины острой дыхательной недостаточности, возникающей при травме груди: {

~%33.33333% Травма ребер.

~%33.33333% Травма легкого.

~%33.33333% Ушиб сердца.

~%-100%Травма печени.

}

Укажите транспортное положение пострадавшего без сознания с травмой груди.

{

~ Полусидя.

~ Лежа на спине.

= Лежа на поврежденном боку

~ Сидя

}

Укажите признаки травмы позвоночника с повреждением спинного мозга. {
~%33.33333% Боль в области травмы.
~%33.33333% Снижение или отсутствие чувствительности в конечностях.
~%-100% Понижение температуры тела.
~%33.33333% Отсутствие движения (паралич) конечностей.
}

Укажите, в каких случаях пострадавшим в ДТП накладывается
«шейный воротник» или «воротниковая шина», изготовленная из подручных материалов. {
~ Травма или подозрение на травму шейного отдела позвоночника.
=Всем пострадавшим в ДТП.
~ Только при подозрении на черепно-мозговую травму.
~При повреждении сонной артерии
}

Укажите признаки открытых переломов. {
~%25% Наличие раны в области травмы.
~%-100% Понижение температуры тела.
~%25% Деформация конечности.
~%25% Кровотечение в месте травмы.
~%25% Наличие в ране костных отломков.
}

~Укажите достоверный признак открытого перелома. {
~ Наличие раны в области травмы.
~ Боль в области травмы.
= Наличие в ране костных отломков.
~ Кровотечение в месте травмы.
~ Отек в области травмы.
}

Термин «иммобилизация» означает: {
~ Придание удобного положения поврежденной части тела пострадавшего.
=Создание неподвижности поврежденной части тела пострадавшего.
~ Способ транспортировки пострадавшего.
~Наложение давящей повязки
}

Для иммобилизации поврежденных конечностей используют шины, изготовленные из подручных материалов: {
~%33.33333% Доски.
~%33.33333% Картон.
~%-50%Металлические пруты.

~%33.33333% Лыжи.
~%-50% Поясной ремень.
}

Укажите, в каком положении транспортируют пострадавшего с травмой грудной клетки. Пострадавший в сознании {
~ Лежа на спине.
= В положении полусидя.
~ Лежа на животе.
~ На боку.
}

Укажите, в каком положении транспортируют пострадавшего с травмой грудной клетки. Пострадавший без сознания. {
~ Лежа на спине.
~ В положении полусидя.
~ Лежа на животе.
= Лежа на боку.
}

Пострадавшего нельзя поить, если у него: {
~%50% Подозрение на травму живота.
~%-50% Сдавливание нижних конечностей.
~%50% Отсутствует сознание.
~%-50% Обширные ожоги.
}

Перечислите простейшие приемы обезболивания. {
~%33.33333% Придание пострадавшему удобного положения.
~%33.33333% Иммобилизация поврежденного участка тела.
~%33.33333% «Холод» на область травмы.
~%-100% «Тепло» на область травмы.
}

Меры оказания первой помощи при закрытом переломе {
~ наложение давящей повязки
= иммобилизация, холод на место перелома
~ тугая циркулярная повязка
~ тепло на место перелома
}

При оказании первой помощи при вывихе необходимо: {
~ попытаться вправить вывих
~ дать обезболивающее
~ наложить тугую повязку на сустав

= иммобилизовать конечность, приложить холод, вызвать скорую помощь
}

При переломе плечевой кости производят иммобилизацию следующих суставов: {

~ только места перелома

~ места перелома и лучезапястного сустава

= лучезапястного, локтевого и плечевого суставов

~ места перелома, локтевого и плечевого суставов

}

Положение, придаваемое пострадавшему с переломом костей черепа при транспортировке: {

~ горизонтальное

= горизонтальное, голова фиксирована и повёрнута в сторону

~ полусидячее

~ лёжа на щите

}

Транспортировка пострадавшего с переломом костей таза осуществляется в положении: {

~ лежа на боку

= «лягушки», с валиком под коленными суставами

~ лежа на животе

~ на щите с валиком под шеей

}

Транспортировка пострадавшего с переломом позвоночника осуществляется в положении: {

~ лежа на боку

~ «лягушки», с валиком под коленными суставами

~ лежа на животе

= лёжа на спине на щите

}

Признаками перелома являются все перечисленные симптомы, кроме: {

= пружинистая фиксация, удлинение конечности

~ боль, кровоподтёки

~ крепитация

~ укорочение конечности

}

При переломе голени необходимо обездвижить: {

~ только места перелома

~ места перелома и коленного сустава

= места перелома, коленный и голеностопный суставы

~ места перелома, тазобедренного, коленного и голеностопного суставов
}

Признаками вывиха являются все перечисленные симптомы, кроме: {

~ боль и деформация конечности
= крепитация, патологическая подвижность в месте травмы
~ нефизиологическое положение конечности
~ пружинистая фиксация
}

При переломе костей предплечья производится иммобилизация: {

~ только места перелома
~ места перелома и лучезапястного сустава
= места перелома, лучезапястный и локтевой суставы
~ места перелома, локтевого и плечевого суставов
}

Меры оказания первой помощи при ушибе: {

~ грелку на место ушиба
= холод, тугая повязка, обезболивание
~ растирание места ушиба
~ согревающий компресс на место ушиба
}

Признаки перелома ребер: {

~ боль в грудной клетке в покое
= боль в грудной клетке усиливается при кашле, чихании
~ боль в грудном отделе позвоночника
~ боль в грудной клетке при наклоне головы
}

Первая помощь при открытом переломе, сопровождающемся повреждением артерии {

~ наложить жгут, асептическая повязка
~ иммобилизация
~ наложить повязку, обезболивающее, транспортировка в лечебное учреждение
= наложить жгут, асептическую повязку, иммобилизация, вызвать скорую помощь
}

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания: {

~ наложить жгут, растирание
~ холод, обезболивающее
= тугая повязка, холод, иммобилизация
~ обложить конечность грелками
}

Тема: Оказание первой помощи при термических повреждениях. Оказание первой помощи при несчастных случаях

Признаки синдрома верхней полой вены (травматической асфиксии): {

- ~%33.33333% лицо и шея одутловаты, багрово-синюшного цвета;
 - ~%-25% прогрессирующее снижение артериального давления;
 - ~%33.33333% мелкоточечные кровоизлияния в области грудной клетки и шеи;
 - ~%33.33333% кровотечение из носа и ушей;
 - ~%-25% наличие раны грудной клетки;
 - ~%-25% кровь в ране пузырится;
 - ~%-25% непроизвольное мочеиспускание.
- }

При поражении человека электрическим током в первую очередь необходимо: {

- ~ проверить пульс на сонной артерии;
 - ~ проверить наличие дыхания;
 - ~ приступить к закрытому массажу сердца;
 - ~ приступить к проведению искусственных вдохов;
 - = прекратить воздействие электрического тока.
- }

Первая помощь при отравлении угарным газом: {

- = вынести пострадавшего на свежий воздух;
 - ~ обильное промывание желудка;
 - ~ выпить 0,5 стакана раствора активированного угля;
 - ~ принять сердечные препараты;
 - ~ освободить пострадавшего от стягивающей одежды.
- }

Первая помощь при попадании инородных тел в дыхательные пути взрослого: {

- ~%33.33333% перегнуть через спинку кресла, скамейки или собственное бедро;
 - ~%33.33333% ударить несколько раз раскрытой ладонью между лопатками;
 - ~%-50% ударить несколько раз кулаком между лопатками;
 - ~%-50% ударить несколько раз ребром ладони между лопатками;
 - ~%33.33333% уложить пострадавшего на спину, запрокинуть голову и попытаться удалить инородное тело пинцетом или корнцангом.
- }

Действия в случае укуса змей и ядовитых насекомых {

- ~%25%удалить жало из раны
- ~%25%приложить холод к месту укуса

~%25%дать обильное и желательно сладкое питье
~%-50%при потере сознания больного оставить лежа на спине
~%-50%использовать грелку и согревающие компрессы
~%25%при потере сознания больного повернуть на живот
}

Действия в случае отравления ядовитыми газами {
~%50%вынести на свежий воздух, в случае отсутствия сознания и пульса на сонной артерии приступить к комплексу реанимации, вызвать скорую помощь
~%50%в случае потери сознания более 4 минут — повернуть на живот и приложить холод к голове
~%-50%искусственное дыхание изо рта в рот проводить без использования специальных масок
~%-50% вызвать рвоту
}

Признаки бледного утопления {
~%25%бледно серый цвет кожи
~%25%широкий нереагирующий на свет зрачок
~%25%отсутствие пульса на сонной артерии
~%25%часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта
~%-50%набухание сосудов шеи
~%-50%отсутствие пульса у лодыжек
}

Признаки истинного утопления {
~%33.33333%кожа лица и шеи с синюшным отеком
~%33.33333%набухание сосудов шеи
~%33.33333%обильные пенистые выделения изо рта и носа
~%-33.33333%широкий нереагирующий на свет зрачок
~%-33.33333%отсутствие пульса на сонной артерии
~%-33.33333%часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта
}

При признаках закупорки дыхательных путей умеренной степени следует выполнить следующие мероприятия первой помощи: {
~ постучать основанием ладони в межлопаточную область пострадавшего для извлечения инородного тела;
= предложить пострадавшему откашляться;
~ выполнить 5 резких толчков в подвздошную область живота пострадавшего;
~ в этом случае мероприятия первой помощи не требуются.
}

Выберите основные признаки закупорки инородным телом верхних дыхательных путей тяжелой степени у пострадавшего: {

= не может дышать или дыхание явно затруднено (шумное, хриплое), хватается за горло, не может говорить, только кивает;
~ хватается за горло, кашляет, просит о помощи;
~ надрывно кашляет, пытается что-то сказать, лицо багровеет;
~ жалуется на наличие инородного тела в дыхательных путях, говорит, что «поперхнулся», просит постучать по спине.
}

Пострадавший внезапно потерял сознание. Дыхание присутствует. Выберите необходимое действие: {

= следует уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение (позу восстановления, стабильное боковое положение);
~ для профилактики возможного вдыхания рвотных масс необходимо уложить пострадавшего на живот;
~ голову пострадавшего набок;
~ для скорейшего восстановления сознания необходимо надавить пострадавшему на болевые точки (угол нижней челюсти, верхняя губа и т. д.);
~ следует дать понюхать нашатырный спирт на ватке;
~ необходимо придать положение на спине с приподнятыми ногами для обеспечения лучшего кровоснабжения головного мозга пострадавшего.
}

При полной закупорке инородным телом верхних дыхательных путей оказание первой помощи следует начать с действия: {

~ попытаться удалить инородное тело резким ударом в верхнюю часть живота
= спросить пострадавшего: «Вы подавились? Разговаривать сможете?»;
~ нанести несколько ударов в межлопаточную область, наклонив пациента вперед;
~ вызвать скорую медицинскую помощь;
~ попытаться вызвать рвоту у пациента, надавив двумя пальцами на корень языка;
~ выяснить у пострадавшего, чем он подавился.
}

Беременная женщина подавилась, не может ни говорить, ни кашлять, хватается за горло. Какую первую помощь необходимо оказать? {

~ 5 ударов между лопатками, если инородное тело не вышло – 5 толчков в живот;
= 5 ударов между лопатками, если инородное тело не вышло – 5 толчков в грудину;
~ 5 ударов между лопатками, если инородное тело не вышло – 5 вдохов;
~ 5 толчков в грудину, если инородное тело не вышло – 5 вдохов.
}

Первая помощь при утоплении, после извлечения пострадавшего из воды: {

~ удалить воду из дыхательных путей, проверить дыхание, если его нет – провести сердечно-легочную реанимацию;

~ проверить дыхание, если его нет – осуществить искусственное дыхание;
= проверить дыхание, если его нет – осуществить сердечно-легочную реанимацию;
~ удалить воду из дыхательных путей, проверить дыхание, если его нет –
осуществить искусственное дыхание.
}

Первая помощь при электротравме заключается в следующем: {
= прекратить действие тока, вызвать скорую медицинскую помощь,
определить наличие признаков жизни;
~ вызвать скорую медицинскую помощь, прекратить действие тока, следить за
признаками жизни;
~прекратить действие тока, проверить признаки жизни, вызвать скорую
медицинскую помощь;
~ последовательность действий не имеет значения.
}

При подозрении на отравление пострадавшего ядовитым веществом,
поступившим в его организм через желудочно-кишечный тракт, необходимо: {
~%25% вызвать скорую медицинскую помощь;
~%25% предложить пострадавшему вызвать рвоту (если он в сознании);
~%25% собрать образцы яда для анализа;
~%25% дать пострадавшему попить воды;
~%-100% открыть окно, уложить и охладить голову
}

Ваши действия при первой помощи подавившемуся пострадавшему, который
находиться в сознании, не может говорить, наблюдается кашель: {
~ хлопнуть ладонью по спине пока не откашляется
~ выполнить два полных вдувания в легкие через рот
~ двумя пальцами надавить на корень языка пострадавшего
~ попытаться извлечь инородное тело пальцами или пинцетом
= обхватить пострадавшего сзади и сложенными в замок кистями сильно надавить
под диафрагму
}

Как оказать первую медицинскую помощь при отравлении угарным газом? {
~ уложить, согреть, напоить горячим напитком.
= вынести на чистый воздух, растереть тело, протереть виски нашатырным
спиртом.
~ перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область сердца с
помощью холодных компрессов
~ открыть окно, уложить и охладить голову
}

Какую первую помощь необходимо оказать человеку, попавшему под разряд молнии? {

= провести реанимационные мероприятия, срочно госпитализировать

~ закопать пострадавшего в землю

~ дать обезболивающее средство

~ провести ИВЛ

}

Правила перемещения в зоне "шагового" напряжения: {

= передвигаться следует в диэлектрических ботах или галошах либо «гусиным шагом» – пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. под шаговое напряжение можно попасть в радиусе 8 м от места касания электрического провода земли.

~ передвигаемся бегом, отрываем подошвы от земли, широкими шагами.

~ прикасаемся к пострадавшему без предварительного обесточивания.

~ прикасаемся к металлическим предметам без предварительного обесточивания.

}

Каков порядок освобождения от действия электрического тока при напряжении выше 1000 В? {

~%20% надеть диэлектрические перчатки, резиновые боты или галоши

~%20% взять изолирующую штангу или изолирующие клещи

~%20% замкнуть провода вл 6-20 кв накоротко методом наброса, согласно специальной инструкции

~%20% сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего

~%20% оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 м от места касания провода земли или от оборудования, находящегося под напряжением

~%-100% отбросить металлическим предметом без предварительного обесточивания.

}

Признаки бледного утопления: {

~%25% бледно серый цвет кожи

~%25% широкий не реагирующий на свет зрачок

~%25% отсутствие пульса на сонной артерии

~%25% часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта

~%-50% набухание сосудов шеи

~%-50% отсутствие пульса у лодыжек

}

Признаки истинного утопления: {

~%33.33333% кожа лица и шеи с синюшным отеком

~%33.33333% набухание сосудов шеи

~%-33.33333% обильные пенистые выделения изо рта и носа

~%33.33333% широкий не реагирующий на свет зрачок

~%-33.33333% отсутствие пульса на сонной артерии
~%-33.33333% часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта
}

Действия в случае укуса змей и ядовитых насекомых: {
~%25% удалить жало из раны
~%25% приложить холод к месту укуса
~%25% дать обильное и желательно сладкое питье
~%-50% при потере сознания больного оставить лежа на спине
~%-50% использовать грелку и согревающие компрессы
~%25% при потере сознания больного повернуть на живот
}

Утопление – это один из видов ... {
= острой дыхательной недостаточности
~ острой сердечно-сосудистой недостаточности
~ хронической дыхательной недостаточности
~ нарушения деятельности центральной нервной системы
}

Различают следующие типы утопления: {
~%33.33333% синкопальное
~%-100% постепенное
~%33.33333% истинное
~%33.33333% асфиксическое
}

Пути проникновения яда в организм: {
~%33.33333% с пищей, с водой
~%33.33333% через дыхательные пути
~%33.33333% через рану
~%-100% с атмосферными осадками
}

При попадании отравляющего вещества в дыхательные пути в первую очередь необходимо: {
~ начать сердечно-легочную реанимацию
= вынести или вывести пострадавшего на свежий воздух
~ начать искусственное дыхание
~ начать ингаляции кислорода, увлажненного спиртом
}

Первая помощь при утоплении: {
~ уложив пострадавшего животом на бедро, чтобы голова пострадавшего свисала к земле, энергично нажимая на грудь, удалить воду из желудка и легких, далее

приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
= уложив пострадавшего животом на бедро, чтобы голова пострадавшего свисала к земле, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких, далее приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

~ уложив пострадавшего животом на бедро, чтобы голова пострадавшего свисала к земле, энергично нажимая на спину, удалить воду из желудка и легких, далее приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

~ уложив пострадавшего животом на бедро, чтобы голова пострадавшего свисала к земле, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких, далее приступить к проведению искусственного дыхания.

~ уложив пострадавшего животом на бедро, чтобы голова пострадавшего свисала к земле, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких, далее приступить к непрямого массажа сердца.

}

Признаки утопления: {

= выделение пены изо рта, остановка дыхания и сердечной деятельности, посинение кожных покровов, расширение зрачков.

~ выделение пены изо рта.

~ выделение пены изо рта, остановка дыхания.

~ выделение пены изо рта, остановка дыхания и сердечной деятельности, расширение зрачков.

~ выделение пены изо рта, остановка дыхания и сердечной деятельности, посинение кожных покровов.

}

Первая помощь при электротравме: {

~ немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем выключения рубильника, перерубания электропровода, при нарушении дыхания или внезапной остановки сердца, приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

~ немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем выключения рубильника, перерубания электропровода, при нарушении дыхания или внезапной остановки сердца, приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

~ немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем выключения рубильника, отброса или перерубания электропровода, при нарушении дыхания или внезапной остановки сердца, приступить к проведению искусственного дыхания.

= немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем выключения рубильника, отброса или перерубания электропровода, при нарушении дыхания или внезапной остановки сердца, приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

~ немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем выключения

рубильника, отброса или перерубания электропровода, при нарушении дыхания или внезапной остановки сердца, приступить к проведению непрямого массажа сердца.

}

Первая помощь при попадании кислоты на кожу. {

~ положить пузырь со льдом

~ дать рвотные средства

= кожу сразу промыть под струей воды, можно использовать мыло или слабый раствор щелочи (2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевая сода)

~ необходимо провести промывание желудка 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевая сода) 2-3 л.

}

~Первая помощь при отравлении щелочами «через рот». {

~рекомендуется принимать рвотные средства

~рекомендуется принимать слабительное

~ дать теплое питье (чай, кофе)

=необходимо срочно промыть желудок чистой кипяченной водой 2-3 л.

}

Первая помощь при отравлении, которое связано с употреблением грибов в пищу {

=необходимо вызвать рвоту и сделать промывание желудка (нужно выпить большое количество чистой воды 2-3 л. и раздражать корень языка пальцами, что приведет к рефлексорной рвоте)

~ принять пищу

~пострадавшего уложить, согреть с помощью грелок

~дать обильное питье (чай, вода)

}

Первая помощь при отравлении недоброкачественной пищей. {

~рекомендуется выпить теплое молоко

~дать солевое слабительное

=необходимо промыть желудок до чистых промывных вод, выпивают большое количество чистой воды до 2-3л. или 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевая сода) 2-3 л.

~принять пищу

}

Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями. {

~принять пищу

~проведение дезинфекции в жилом помещении, где находится пострадавший

~искусственная вентиляция легких

=промыть желудок 0,1% раствором калия перманганата (слабо-розовый раствор марганца), или чистой водой до 2-3л.
}

Первая помощь при отравлении атропиносодержащими растениями (красавка, белена, дурман): {

= произвести промывание желудка чистой водой до чистых промывных вод до 2-3л

~рекомендуется выпить теплое молоко

~искусственная вентиляция легких

~дать понюхать с ватки нашатырный спирт

}

Первая помощь при ожогах: {

= холод, наложение стерильной повязки.

~смазывание обожжённой поверхности мазью

~обработка обожжённой поверхности спиртом

~обработка обожжённой поверхности перекисью водорода

}

Первая помощь в случае алкогольного отравления в бессознательном состоянии. {

~вызвать рвотный рефлекс

~промыть желудок 2-3 л воды с добавлением пищевой соды (1ч.л. соды на 1л воды), т.е 2 % раствором гидрокарбоната натрия или чистой водой

=уложить пострадавшего на живот, чтобы избежать попадания рвотных масс в дыхательные пути при рвоте, которая может возникнуть спонтанно

~дать слабительное

}

Первая помощь при отравлении раствором уксусной кислоты. {

=промывание желудка холодной водой (2-3 л.)

~дать слабительное и рвотные средства

~дать активированный уголь

~ искусственная вентиляция легких

}

Первая помощь при вдыхании паров уксусной кислоты. {

~дать рвотные средства

~ промыть желудок 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевая сода) или чистой водой

=следует прополоскать горло и промыть нос 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевая сода)

~ рекомендуется выпить теплое молоко с содой или щелочную минеральную воду (Боржоми)

}

Порядок действий при оказании помощи пораженному электрическим током: {
~Начать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
~Провести диагностирование, начать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
= Обесточить пострадавшего, провести диагностирование, при необходимости приступить к реанимационным мерам.
~Вызвать скорую помощь
}

Местные признаки ожога I степени: {
= жжение, боль
~пузыри со светлым содержимым
~пузыри с тёмным содержимым
~образование струпа
}

Местные признаки ожога II степени: {
~жжение, боль
= жжение, боль, пузыри со светлым содержимым
~ пузыри с тёмным содержимым
~образование
}

Во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой температурой воздуха и влажностью возможен. {
~солнечный удар;
~ травматический шок;
~травматический токсикоз;
= тепловой
}

У пострадавшего на пожаре поражены ткани, лежащие глубоко (подкожная клетчатка, мышцы, сухожилия, нервы, сосуды, кости), частично обуглены ступни, какая у него степень ожога. {
~ I
~II
~IIIa
~IIIб
=IV
}

Укажите вещество, при отравлении которым кожные покровы пострадавшего становятся розовыми. {
~Метиловый спирт.

~Снотворные вещества.
= Угарный газ.
~Хлор.
~Наркотические
}

Укажите основные причины утопления. {
~%33.33333% Попадание воды в легкие во время произвольных дыхательных движений под водой.
~%33.33333% Рефлекторная остановка сердца при внезапном попадании в холодную воду.
~%33.33333% Спазм голосовых связок при попадании на них воды.
~%-100% Паралич дыхательного центра головного мозга.
}

Пострадавший, спасенный после утопления, должен быть госпитализирован: {
~ После состояния клинической смерти.
~ После продолжительной потери сознания.
~После кратковременной потери сознания.
= Во всех случаях утопления.
}

Прием Геймлиха (прием удаления инородного тела из верхних дыхательных путей) у пострадавших с ожирением и у беременных женщин выполняют путем сжатия в области: {
~ Верхней части грудины.
= Нижней части грудины.
~Верхней части живота.
~При боковом сдавливании грудной клетки.
}

Перечислите группы пострадавших, которым нельзя применять прием удаления инородного тела из верхних дыхательных путей при помощи сжатия брюшной полости. {
~%33.33333% Беременные женщины.
~%33.33333% Тучные люди.
~%-50%Пожилые люди.
~%33.33333% Младенцы.
~%-50%Подростки
}

В первом периоде переохлаждения (стадия компенсации) наблюдаются: {
~%-25% бледность кожи;
~%33.33333%покраснение кожи;
~%33.33333%мышечная дрожь;

~%-25% отсутствие мышечной дрожи;
~%-25% снижение температуры тела;
~%33.33333%температура тела практически не изменяется;
~%-25% сонливость.
}

Во втором периоде переохлаждения (стадия декомпенсации) наблюдаются: {
~%-25% сужение сосудов кожи;
~%33.33333%расширение сосудов кожи;
~%33.33333%сонливость;
~%-25% возбуждение;
~%33.33333%температура тела прогрессивно снижается;
~%-25% температура тела сохраняется в пределах 35 С;
~%-25% озноб.
}

Первая помощь при отморожении пальцев рук (ног): {
~%-25% энергично растереть кисти (стопы) снегом;
~%33.33333%провести энергичный массаж конечности (можно со спиртом);
~%33.33333%дать обезболивающее;
~%-25% дать снотворное;
~%-25% сделать ванночку для кисти (стопы) с температурой воды 36 С;
~%33.33333%сделать ванночку для кисти (стопы) с температурой 22 С с постепенным ее повышением до 37-40 С;
~%-25% наложить асептическую повязку.
}

Признаки отморожения I степени: {
~%50% побледнение кожи;
~%-33.33333%покраснение кожи;
~%50% потеря чувствительности поврежденного участка кожи;
~%-33.33333%пузыри с прозрачным желеобразным содержимым;
~%-33.33333%длительный период заживления с образованием рубцов.
}

Первая помощь при общем переохлаждении: {
~%-33.33333%энергично растереть тело снегом;
~%50% провести энергичное растирание (массаж) поверхности тела, можно водкой;
~%-33.33333%накормить;
~%-33.33333%поместить в ванну с температурой воды 36 С;
~%50% поместить в ванну с температурой воды 20-22 С с постепенным ее повышением до 30 С.
}

Признаки переохлаждения{

~%25%озноб и дрожь

~%25%нарушение сознания: заторможенность и апатия, бред и галлюцинации, неадекватное поведение

~%25%посинение или побледнение губ

~%25%снижение температуры тела

~%-50%потеря чувствительности

~%-50%нет пульса у лодыжек

}

Что делать, если ребенок получил ожог пламенем, кипятком или паром?{

= вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и одновременно с этим охлаждать место ожога холодной проточной водой не менее 20 минут

~ вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и одновременно с этим приложить холодный предмет к месту ожога, предварительно обернув его куском ткани

~ вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком

~ вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать и обработать спиртом

}

Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль)?{

~ Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать

~ Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, поить пострадавшего водой

= Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и поить пострадавшего водой

~ накрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать

}

Признаки переохлаждения{

~%-50% нет пульса у лодыжек

~%25% посинение или побледнение губ

~%25% озноб и дрожь

~%25% нарушение сознания: заторможенность и апатия, бред и галлюцинации, неадекватное поведение

~%25% снижение температуры тела

~%-50% потеря чувствительности

}

При глубоком ожоге необходимо оказать следующую первую помощь: {
~ накрыть ожог влажной салфеткой, вызвать скорую медицинскую помощь, принять противошоковые меры;
~ охладить место ожога, затем накрыть ожог влажной салфеткой;
= охладить место ожога, затем наложить влажную повязку, вызвать скорую медицинскую помощь;
~ вызвать скорую медицинскую помощь, обработать пораженную область перекисью водорода.
}

В случае развития отморожения конечности наиболее важно: {
~ укутать пострадавшего;
= наложить на конечность термоизолирующую повязку;
~ как можно скорее поместить отмороженную конечность в теплую воду;
~ растереть конечность шерстяной тканью;
~ напоить пострадавшего теплым чаем.
}

Тепловой удар возникает при: {
= накоплении тепла в организме, в связи с длительным воздействием высокой температуры
~ длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову или обнаженное тело
~ накоплении тепла в организме, в связи с длительным воздействием низкой температуры
~ длительном воздействии высокой температуры на организм человека
}

Солнечный удар возникает при: {
~ накоплении тепла в организме, в связи с длительным воздействием высокой температуры
= длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову или обнаженное тело
~ накоплении тепла в организме, в связи с длительным воздействием низкой температуры
~ длительном воздействии высокой температуры на организм человека
}

В рамках первой помощи при ожогах необходимо: {
~ доставить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, наложить чистую влажную повязку, покой, противошоковые меры
= убрать поражающий фактор, охладить место ожога, наложить чистую влажную повязку, покой, противошоковые меры, вызвать скорую помощь

~ срочно вызвать врача или скорую помощь, противошоковые меры, охладить место ожога
~ убрать поражающий фактор, место ожога освободить от одежды, наложить повязку, вызвать скорую помощь
}

Укажите основное мероприятие первой помощи при ожоге: {
= охладить пораженный участок тела
~ приложить холод, усадить, наклонить голову вперед и вниз
~ остановить кровотечение
~ наложить давящую повязку
~ доставить в теплое место
~ наложить шину
}

Какие меры по оказанию первой помощи пострадавшему необходимо предпринять в случае термических ожогов? {
~ прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, снять горящую одежду, смазать пузыри кремом или жиром и наложить сухую повязку
= прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, обрезать одежду вокруг ожогов, наложить сухую стерильную повязку, дать обезболивающее, обильное питье
~ прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, снять горящую одежду, смазать пузыри кремом или жиром и наложить сухую повязку, дать обезболивающее
~ снять горящую одежду, смазать пузыри кремом или жиром и наложить сухую повязку
}

В каком случае переохладение считается легким? {
~ если температура тела человека не опустилась ниже 36°C
= если температура тела человека не опустилась ниже 34°C
~ если температура тела человека не опустилась ниже 32°C
~ если температура тела человека не опустилась ниже 35°C
}

Как оказать первую медицинскую помощь при термическом ожоге? {
~ укутать конечность подручным материалом.
~ наложить холодный компресс.
= наложить стерильную повязку.
~ промыть холодной водой
}

Как оказать первую медицинскую помощь при химическом ожоге? {
= обильно промыть холодной водой, наложить стерильную повязку.

- ~ обработать края раны настойкой йода, наложить стерильную повязку.
 - ~ промыть перекисью водорода, наложить стерильную повязку.
 - ~ обработать перманганатом, наложить стерильную повязку
- }

Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль)? {

- ~ полить ожоговую поверхность холодной водой, смазать спиртовой настойкой йода, накрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать. дать болеутоляющее средство из индивидуальной аптечки.
 - ~ вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, поить пострадавшего водой.
 - = пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод и поить пострадавшего водой.
 - ~ дать болеутоляющее средство из индивидуальной аптечки
- }

Признаки переохлаждения: {

- ~%25% озноб и дрожь
 - ~%25% нарушение сознания: заторможенность и апатия, бред и галлюцинации, неадекватное поведение
 - ~%25% посинение или побледнение губ
 - ~%25% снижение температуры тела
 - ~%-50% потеря чувствительности
 - ~%-50% нет пульса у лодыжек
- }

Укажите признаки термических ожогов 1 степени: {

- = гиперемия обожженного участка, чувство боли и жжения
 - ~ гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются прозрачные пузыри
 - ~ кожа бледная, беспокоит чувство боли или жжения
 - ~ гиперемия обожженного участка, чувствительность резко снижена, боли нет
- }

Укажите признаки термических ожогов 2 степени: {

- = гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются прозрачные пузыри
- ~ гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются геморрагические пузыри и обрывки вскрывшихся пузырей
- ~ кожа пораженного участка багрово-синюшная, определяются прозрачные пузыри

~ имеется сухая раневая поверхность, окруженная струпом
}

Укажите признаки термических ожогов 4 степени: {

= темно-коричневый плотный струп, кожа вокруг темная, просвечивают тромбированные подкожные вены, сильная боль

~ темно-коричневый плотный струп, кожа вокруг струпа практически не изменена, боль умеренная

~ кожа темная, до черного цвета, мумификация пораженного участка, чувствительности в пораженном участке нет

~ беловатый, рыхлый струп, кожа вокруг струпа гиперемирована, боль умеренная
}

Первая помощь при тепловом ударе: {

~ пострадавшего срочно вынести в прохладное место, обеспечить доступ свежего воздуха, напоить холодной водой, наложить холодный компресс на голову, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца.

= пострадавшего срочно вынести в прохладное место, обеспечить доступ свежего воздуха, освободить от одежды, напоить холодной водой, наложить холодный компресс на голову, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца.

~ пострадавшего срочно вынести в прохладное место, обеспечить доступ свежего воздуха, освободить от одежды, наложить холодный компресс на голову, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца.

~ пострадавшего срочно вынести в прохладное место, обеспечить доступ свежего воздуха, освободить от одежды, напоить холодной водой, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца.

~ пострадавшего срочно вынести в прохладное место, освободить от одежды, напоить холодной водой, наложить холодный компресс на голову, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца.
}

Первая помощь при обморожениях: {

~ пострадавшего внести в теплое помещение, снять обувь и перчатки, обмороженную конечность вначале растереть сухой тканью, затем поместить в таз с теплой 30...32,5°C водой и в течение 10 мин температуру воды довести до 41,5°C, вытереть насухо обмороженную конечность и протереть 33% раствором спирта, наложить асептическую или чистую повязку (можно надеть чистые проглаженные носки или перчатки), при общем охлаждении пострадавшего необходимо тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем.

= пострадавшего внести в теплое помещение, снять обувь и перчатки,

обмороженную конечность вначале растереть сухой тканью, затем поместить в таз с теплой 32...34,5°C водой и в течение 10 мин температуру воды довести до 40,5°C, вытереть насухо обмороженную конечность и протереть 33% раствором спирта, наложить асептическую или чистую повязку (можно надеть чистые проглаженные носки или перчатки), при общем охлаждении пострадавшего необходимо тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем.

~ пострадавшего внести в теплое помещение, снять обувь и перчатки, обмороженную конечность вначале растереть сухой тканью, затем поместить в таз с теплой 31...33,5°C водой и в течение 10 мин температуру воды довести до 42,5°C, вытереть насухо обмороженную конечность и протереть 33% раствором спирта, наложить асептическую или чистую повязку (можно надеть чистые проглаженные носки или перчатки), при общем охлаждении пострадавшего необходимо тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем.

~ пострадавшего внести в теплое помещение, снять обувь и перчатки, обмороженную конечность вначале растереть сухой тканью, затем поместить в таз с теплой 32...34,5°C водой и в течение 10 мин температуру воды довести до 43,5°C, вытереть насухо обмороженную конечность и протереть 33% раствором спирта, наложить асептическую или чистую повязку (можно надеть чистые проглаженные носки или перчатки), при общем охлаждении пострадавшего необходимо тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем.

~ пострадавшего внести в теплое помещение, снять обувь и перчатки, обмороженную конечность вначале растереть сухой тканью, затем поместить в таз с теплой 32,5...35,0°C водой и в течение 10 мин температуру воды довести до 40,5°C, вытереть насухо обмороженную конечность и протереть 33% раствором спирта, наложить асептическую или чистую повязку (можно надеть чистые проглаженные носки или перчатки), при общем охлаждении пострадавшего необходимо тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем.

}

Первая помощь при солнечном ударе: {

~ перенести пострадавшего в прохладное помещение, снять с него одежду, положить холод на голову и в область сердца, дать обильное солевое питье, при тяжелых формах приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

= перенести пострадавшего в прохладное помещение или в тень, снять с него одежду, положить холод на голову и в область сердца, дать обильное солевое питье, при тяжелых формах приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

~ перенести пострадавшего в тень, снять с него одежду, положить холод на голову и в область сердца, дать обильное солевое питье, при тяжелых формах приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

~ перенести пострадавшего в прохладное помещение или в тень, снять с него одежду, положить холод на голову и в область сердца, при тяжелых формах приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

~ перенести пострадавшего в прохладное помещение или в тень, положить холод

на голову и в область сердца, дать обильное солевое питье, при тяжелых формах приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
}

Первая помощь при термических ожогах: {

~ кожу обильно промыть проточной водой, при попадании в глаз химического вещества промыть его в течение 10 минут, завязать поврежденный глаз.

~ немедленно удалить одежду, пропитанную химикатом, кожу обильно промыть теплой водой, при попадании в глаз химического вещества промыть его в течение 15 минут, завязать поврежденный глаз.

~ немедленно удалить одежду, пропитанную химикатом, кожу обильно промыть проточной водой, при попадании в глаз химического вещества промыть его в течение 20 минут.

~ немедленно удалить одежду, пропитанную химикатом, кожу обильно промыть проточной водой, при попадании в глаз химического вещества промыть его в течение 30 минут, завязать поврежденный глаз.

= немедленно удалить одежду, пропитанную химикатом, кожу обильно промыть проточной водой, при попадании в глаз химического вещества промыть его в течение 20 минут, завязать поврежденный глаз.

}

Первая помощь при термических ожогах: {

~ немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 5...8 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем.

= немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 10...15 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем.

~ немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 10...12 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем.

~ немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 8...10 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем.

~ немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 15...20 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем.

}

Степеней ожогов: {

~2.

=4.

~3.

~5.

}

Первая помощь при отравлении химическими веществами: {

~ немедленно удалить слюнь из рта пострадавшего, нагнув на чайную ложку кусок марли, платок или салфетку, протереть полость рта, если возникли признаки удушья провести искусственное дыхание, дать выпить 2...3 стакана воды, лучше со льдом, пострадавшего в бессознательном состоянии уложить без подушки на живот, голову повернуть в сторону, при западении языка, а также при судорогах осторожно запрокинуть голову и выдвинуть нижнюю челюсть вперед и вверх.

~ немедленно удалить слюну из рта пострадавшего, нагнув на чайную ложку кусок марли, платок или салфетку, протереть полость рта, если возникли признаки удушья провести искусственное дыхание, дать выпить 2...3 стакана воды, лучше со льдом, пострадавшего в бессознательном состоянии уложить без подушки на живот, голову повернуть в сторону, при западении языка, а также при судорогах осторожно запрокинуть голову и выдвинуть нижнюю челюсть вперед и вверх.

= немедленно удалить слюну и слюнь из рта пострадавшего, нагнув на чайную ложку кусок марли, платок или салфетку, протереть полость рта, если возникли признаки удушья провести искусственное дыхание, дать выпить 2...3 стакана воды, лучше со льдом, пострадавшего в бессознательном состоянии уложить без подушки на живот, голову повернуть в сторону, при западении языка, а также при судорогах осторожно запрокинуть голову и выдвинуть нижнюю челюсть вперед и вверх.

~ немедленно удалить слюну и слюнь из рта пострадавшего, нагнув на чайную ложку кусок марли, платок или салфетку, протереть полость рта, если возникли признаки удушья провести искусственное дыхание, дать выпить 2...3 стакана воды, лучше со льдом, пострадавшего в бессознательном состоянии уложить без подушки на живот, при западении языка, а также при судорогах осторожно запрокинуть голову и выдвинуть нижнюю челюсть вперед и вверх.

~ немедленно удалить слюну и слюнь из рта пострадавшего, нагнув на чайную ложку кусок марли, платок или салфетку, протереть полость рта, если возникли признаки удушья провести искусственное дыхание, дать выпить 2...3 стакана воды, пострадавшего в бессознательном состоянии уложить без подушки на живот, голову повернуть в сторону, при западении языка, а также при судорогах осторожно запрокинуть голову и выдвинуть нижнюю челюсть вперед и вверх.

}

Признаки обморожения: {

~ кожа на пораженных участках холодная бледно-синюшного цвета, чувствительность отсутствует, вялость, безучастность, пульс редкий, температура тела меньше 36°C.

= кожа на пораженных участках холодная бледно-синюшного цвета, чувствительность отсутствует, вялость, безучастность, пульс редкий, температура тела меньше 36,5°C.

~ кожа на пораженных участках холодная бледно-синюшного цвета,

чувствительность отсутствует, вялость, безучастность, пульс редкий, температура тела меньше 36,1°C.

~ кожа на пораженных участках холодная бледно-синюшного цвета, чувствительность отсутствует, вялость, безучастность, пульс редкий, температура тела меньше 35,5°C.

~ кожа на пораженных участках холодная бледно-синюшного цвета, чувствительность отсутствует, вялость, безучастность, пульс редкий, температура тела меньше 36,9°C.

}

Признаки теплового удара: {

~ общая слабость, разбитость, головная, боль, головокружение, шум в ушах, сонливость, жажда.

~ общая слабость, разбитость, головная, боль, головокружение, шум в ушах, сонливость, жажда, тошнота.

~ общая слабость, разбитость, головная, боль, головокружение, шум в ушах, сонливость, жажда, тошнота, покраснение кожных покровов.

= общая слабость, разбитость, головная, боль, головокружение, шум в ушах, сонливость, жажда, тошнота, покраснение кожных покровов, пульс и дыхание учащены, температура повышена, потеря сознания в тяжелых случаях, иногда возникают судороги.

~ общая слабость, разбитость, головная, боль, головокружение, шум в ушах, сонливость, жажда, тошнота, покраснение кожных покровов, пульс и дыхание учащены.

}

Признаки солнечного удара: {

= тошнота, рвота, кровотечение из носа, возможно расстройство зрения, учащаются пульс и дыхание, в ряде случаев отмечаются бессознательное состояние, остановка дыхания и сердечной деятельности, обширные ожоги от солнечных лучей первой степени, могут возникать боли в затылочной области.

~ тошнота, рвота, кровотечение из носа, возможно расстройство зрения, учащаются пульс и дыхание, в ряде случаев отмечаются бессознательное состояние.

~ тошнота, рвота, кровотечение из носа, возможно расстройство зрения, учащаются пульс и дыхание, в ряде случаев отмечаются бессознательное состояние, остановка дыхания и сердечной деятельности.

~ тошнота, рвота, кровотечение из носа, возможно расстройство зрения, учащаются пульс и дыхание, в ряде случаев отмечаются бессознательное состояние, остановка дыхания и сердечной деятельности, обширные ожоги от солнечных лучей первой степени.

~ тошнота, рвота, кровотечение из носа, возможно расстройство зрения, учащаются пульс и дыхание, остановка дыхания и сердечной деятельности, обширные ожоги от солнечных лучей первой степени, могут возникать боли в затылочной области.

}

Первая помощь при термических ожогах: {

~ немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 5...8 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем.

= немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 10...15 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем.

~ немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 10...12 минут,

после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить

пострадавшего горячим чаем.

~ немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 8...10 минут,

после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить

пострадавшего горячим чаем.

~ немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 15...20 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем.

}

Первая помощь при тепловом ударе: {

~ пострадавшего срочно вынести в прохладное место, обеспечить доступ свежего воздуха, напоить холодной водой, наложить холодный компресс на голову, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца.

= пострадавшего срочно вынести в прохладное место, обеспечить доступ свежего воздуха, освободить от одежды, напоить холодной водой, наложить холодный компресс на голову, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца.

~ пострадавшего срочно вынести в прохладное место, обеспечить доступ свежего воздуха, освободить от одежды, наложить холодный компресс на голову, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца.

~ пострадавшего срочно вынести в прохладное место, обеспечить доступ свежего воздуха, освободить от одежды, напоить холодной водой, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца.

~ пострадавшего срочно вынести в прохладное место, освободить от одежды, напоить холодной водой, наложить холодный компресс на голову, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца.

}

Тема: Оказание первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях

Причины потери сознания: {

- ~%50%черепно-мозговая травма;
- ~%50%отравление алкоголем;
- ~%-33.33333%капиллярное кровотечение;
- ~%-33.33333%инородное тело носа;
- ~%-33.33333%острый гастрит

}

Причины потери сознания: {

- ~%-33.33333%растяжение связок;
- ~%50%обморок;
- ~%-33.33333%капиллярное кровотечение;
- ~%50%остановка сердечной деятельности;
- ~%-33.33333%колит

}

Продолжительность обморока составляет ____ минут: {

- = 1–5;
- ~ 5–10;
- ~ 10–15;
- ~ 15–20;
- ~ 25–30.

}

Симптомы обморока: {

- ~%-33.33333% повышение артериального давления;
- ~%50% снижение артериального давления;
- ~%50% побледнение кожных покровов;
- ~%-33.33333% покраснение лица;
- ~%-33.33333% цианоз носогубного треугольника.

}

Первая помощь при обмороке: {

- ~%33.33333% больного уложить;
- ~%-25% приподнять голову;
- ~%33.33333% приподнять ноги;
- ~%-25% дать понюхать флакон с нашатырным спиртом;

~%33.33333% дать понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом;
~%-25% поставить горчичник на затылочную область;
~%-25% поставить горчичник на икроножные мышцы.
}

Возникновению гипертонического криза способствуют: {
~%33.33333% психическое перенапряжение, стресс;
~%-25% длительное нахождение в душном помещении;
~%33.33333% внезапное прекращение приема средств, понижающих давление;
~%-25% переохлаждение;
~%33.33333% резкая перемена погоды;
~%-25% заболевания уха, горла и носа;
~%-25% заболевания легких.
}

Жалобы больного при гипертоническом кризе на: {
~%-25% кашель;
~%33.33333% головную боль с преимущественной локализацией в затылочной области;
~%33.33333% головокружение;
~%-25% боли в правом подреберье;
~%33.33333% тошноту, рвоту;
~%-25% боли в грудной клетке, усиливающиеся на вдохе;
~%-25% локальную боль в области грудной клетки.
}

Первая помощь при гипертоническом кризе: {
~%-33.33333% голову опустить;
~%50% голову приподнять;
~%-33.33333% на голову холодный компресс;
~%50% горчичники на затылочную область или икроножные мышцы;
~%-33.33333% под язык – таблетку нитроглицерина.
}

Симптомы гипертонического криза: {
~%-25% пульс слабого наполнения;
~%33.33333% пульс напряжен;
~%-25% артериальное давление понижено;
~%33.33333% артериальное давление повышено;
~%33.33333% покраснение лица;
~%-25% побледнение лица;
~%-25% цианоз носогубного треугольника.
}

Причины инфаркта миокарда: {

~%-33.33333% хронический гастрит;
~%50% атеросклероз;
~%50% нарушение свертываемости крови с формированием тромба;
~%-33.33333% ослабление иммунозащитных сил организма;
~%-33.33333% нервно-психическое перенапряжение.
}

Факторы риска инфаркта миокарда: {
~%50% нервно-психическое перенапряжение, стресс;
~%-33.33333% нахождение в душном помещении;
~%-33.33333% переохлаждение;
~%-33.33333% пожилой возраст;
~%50% ожирение.
}

Развитие инфаркта миокарда связано с: {
~ наличием врожденного или приобретенного порока сердца;
~ повышением артериального давления;
= нарушением кровообращения в сосудах сердца;
~нарушением кровообращения в сосудах мозга;
~сужением почечной артерии.
}

Характеристика боли при инфаркте миокарда: {
~%50% раздирающая боль за грудиной;
~%-33.33333% боль в грудной клетке при кашле;
~%50% боль отдает в левую половину тела (плечо, лопатку);
~%-33.33333% колющая боль в области сердца;
~%-33.33333% резкая боль в правом или левом боку.
}

Первая помощь при инфаркте миокарда: {
~%33.33333% срочно вызвать врача скорой помощи;
~%33.33333% нитроглицерин под язык каждые 15 минут;
~%-25% горчичники на затылочную область;
~%33.33333% аспирин под язык;
~%-25% сделать закрытый массаж сердца;
~%-25% провести искусственное дыхание;
~%-25% горчичники на область сердца.
}

Инсульт – это: {
= нарушение мозгового кровообращения;
~ нарушение кровообращения в сосудах сердца;
~кратковременная потеря сознания;

- ~резкое повышение артериального давления;
- ~приступ удушья.

}

Ишемический инсульт возникает в результате: {

- ~%-33.33333% спазма артерий сердца;
- ~%50% спазма артерий мозга;
- ~%-33.33333% разрыва артерии мозга;
- ~%50% тромбоза или эмболии артерии мозга;
- ~%-33.33333% тромбоза или эмболии артерии сердца.

}

Геморрагический инсульт возникает в результате: {

- ~ спазма артерий сердца;
- ~ спазма артерий мозга;
- = разрыва артерии мозга;
- ~ тромбоза или эмболии артерии мозга;
- ~тромбоза или эмболии артерии сердца.

}

Предвестники инсульта: {

- ~%-25% синдром «перемежающейся» хромоты;
- ~%33.33333% преходящее онемение конечности;
- ~%33.33333% головокружение;
- ~%33.33333% преходящее расстройство сознания;
- ~%-25% резкие боли в области сердца;
- ~%-25% обморок
- ~%-25% кашель.

}

Первая помощь при инсульте: {

- ~%50% больного уложить, голову приподнять;
- ~%-33.33333% больного уложить, ноги приподнять;
- ~%-33.33333% нитроглицерин под язык каждые 15 минут;
- ~%50% срочно вызвать врача;
- ~%-33.33333% горчичники на затылочную область.

}

Боль при мигрени локализуется преимущественно в ... области: {

- ~%50% височной;
- ~%-33.33333% лобной;
- ~%-33.33333% затылочной;
- ~%-33.33333% теменной;
- ~%50% в одной (правой или левой) половине головы.

}

Симптомы мигрени: {

~%33.33333% сдавливающая головная боль (симптом «каска»);

~%-25% головокружение;

~%33.33333% слезотечение из одного глаза;

~%33.33333% снижение зрения;

~%-25% улучшение зрения;

~%-25% появление симптома «куриной слепоты»;

~%-25% боли в области сердца.

}

Симптомы острой пневмонии: {

~%50% повышение температуры;

~%-33.33333% приступы удушья;

~%50% боли в грудной клетке при дыхании, кашле;

~%-33.33333% боли в правой или левой половине живота;

~%-33.33333% боли жгучего характера за грудиной.

}

Основным симптомом бронхиальной астмы является: {

~ кашель;

~ кровохарканье;

~ повышенная потливость;

~ боль в грудной клетке;

= приступ удушья.

}

При приступе бронхиальной астмы: {

%-25% затруднен вдох;

~%33.33333% затруднен выдох;

%-25% частота дыхания увеличивается;

~%33.33333% редкое дыхание;

%-25% кровохарканье;

%-25% боли в грудной клетке;

~%33.33333% свистящие хрипы при дыхании слышны на расстоянии.

}

Причины развития «острого живота»: {

~%50% непроходимость кишечника;

~%50% разрыв кисты яичника;

%-33.33333% острый гастрит;

%-33.33333% колит;

%-33.33333% дисбактериоз кишечника.

}

Причины развития «острого» живота: {
%-33.33333% острый гастрит;
%-33.33333% колит;
~%50% тупая травма живота с разрывом внутренних органов;
~%50% прободная язва желудка;
%-33.33333% дисбактериоз кишечника.
}

При наличии симптомов «острого» живота разрешено: {
~ кормить, поить;
~ делать очистительную клизму;
~ давать обезболивающее;
= холод на живот;
~ тепло на живот.
}

Симптомы «острого» живота: {
%-33.33333% понижение температуры тела;
~%50% доскообразный живот;
~%50% положительный симптом раздражения брюшины;
%-33.33333% непроизвольная дефекация;
%-33.33333% усиленное слюноотделение.
}

Анафилактический шок является тяжелой формой: {
~ инсульта;
~ инфаркта миокарда;
~ бронхиальной астмы;
~ пневмонии;
= аллергии.
}

Первая помощь при развитии аллергии на внутримышечное введение лекарственного препарата: {
~%-25% отсосать лекарство из ранки места инъекции;
%33.33333% дать противоаллергическое средство;
%33.33333% холод на место инъекции;
~%-25% тепло на место инъекции;
~%-25% горчичники на место инъекции;
%33.33333% в ранку от инъекции закапать 5–6 капель санорина или галазолина;
~%-25% растереть место инъекции.
}

При приеме каустической соды и нашатырного спирта внутрь срочно необходимо: {

- ~ выпить 0,5 стакана 2%-ного раствора пищевой соды;
- ~ принять активированный уголь;
- ~ принять рвотное средство;
- ~ принять сердечные препараты;
- = промыть желудок через толстый резиновый зонд.

}

При приеме уксусной кислоты внутрь срочно необходимо: {

- ~ выпить 0,5 стакана 2%-ного раствора пищевой соды;
- ~ принять активированный уголь;
- ~ принять рвотное средство;
- ~ принять обезболивающие препараты;
- = промыть желудок через толстый резиновый зонд.

}

Признаки комы {

- ~%-50% потеря сознания более чем на 6 минут
- ~%50% потеря сознания более чем на 4 минуты
- ~%50% обязательно есть пульс на сонной артерии
- ~%-50% нет пульса на сонной артерии

}

Признаки обморока {

- ~%50% кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин)
- ~%-50% потеря сознания более 6 мин
- ~%50% потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах
- ~%-50% потеря чувствительности

}

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на бок и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении: {

- ~2 минут
- =3 минут
- ~4 минут
- ~5 минут
- ~6 минут

}

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии) {

- = повернуть пострадавшего на бок, приложить к голове холод
- ~ повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

~повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову холод
~освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову холод
~ освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову холод
}

Какие основные признаки обморока {

~Потеря сознания не более 10 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.
=Потеря сознания не более 3-4 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.
~ Потеря сознания не более 4-5 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.
~ Потеря сознания не более 5-6 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.
}

Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания первой помощи? {

~ На спину с вытянутыми ногами
~ Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушья в результате западания языка, его следует положить на живот, чтобы вызвать рвотный рефлекс
= Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушья в результате западания языка, его следует положить на бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой
~ На спину с подложенным под голову валиком
}

Признаки обморока {

~%50% потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах
~%50% кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин)
~%-50% потеря чувствительности
~%-50% потеря сознания более 6 мин
}

Во время оказания первой помощи пострадавший внезапно побледнел, перестал реагировать на окружающее. Укажите, с чего вы начнете оказывать первую помощь: {

~ проверите признаки дыхания;
~ откроете дыхательные пути;
~ позовете помощника;
~ начнете компрессию грудной клетки;
~ осмотрите пострадавшего;
~ сделаете 2 вдоха искусственной вентиляции легких;
= проверите признаки сознания (потрясете пострадавшего и спросите: «Что с Вами?»).

}

Пострадавшему с признаками травмы живота и таза рекомендуется придать следующее положение: {

~ положение на спине с приподнятыми ногами;
~ устойчиво боковое положение;
~ сидячее положение;
= положение на спине с полусогнутыми и разведенными ногами;
~ положение на животе.

}

Если вы стали свидетелем неотложной ситуации и готовы помочь, первое, что необходимо сделать, это: {

~ осмотреть пострадавшего на предмет опасных для жизни состояний;
~ позвать помощника;
~ вызвать экстренные службы;
= осмотреть место происшествия на предмет имеющейся опасности для вас и пострадавшего.

}

При обмороке в рамках первой помощи следует: {

~%-33.33333% положить пострадавшего горизонтально и поднять ноги
~%33.33333% обеспечить приток свежего воздуха
~%-33.33333% привести пострадавшего в сознание, похлопав его по щекам
~%-33.33333% дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт
~%33.33333% положить пострадавшего на бок и поднять ноги выше головы
~%33.33333% вызвать скорую помощь, если пострадавший не приходит в сознании в течение 5-7 мин

}

Чем состояние комы отличается от обморочного состояния? {

~ потеря сознания более чем на 2 минуты
= потеря сознания более чем на 5 минуты
~ ничем не отличается
~ при обмороке - не более 1 минуты

}

Как оказать первую помощь при обмороке? {

= уложить, приподняв ноги, обеспечить приток свежего воздуха, протереть лицо холодной водой.

~ перенести в прохладное место, уложить

~ уложить, согреть, напоить горячим напитком

~ охлаждать голову и область сердца, напоить холодным напитком.

}

Какие основные признаки обморока? {

~ потеря сознания не более 1-2 минут, предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.

~ потеря сознания не более 2-3 минут, предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.

= потеря сознания не более 3-4 минут, предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.

~ потеря сознания не более 4-5 минут, предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.

~ потеря сознания не более 5-6 минут, предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.

}

Приоритетная цель помощи при обмороке {

= восстановление сознания

~ нормализация пульса

~ повышение артериального давления

~ уменьшение одышки

}

«Острый живот» – это ... {

~ симптом патологии органов брюшной полости

= синдром, характеризующийся болями в животе и симптомами раздражения брюшины

~ диагностическое понятие при патологии органов брюшной полости

~ диагностическое понятие, заменяющее диагноз

}

Клинические формы ишемических заболеваний сердца: {

~50% приступ стенокардии

~50% инфаркт миокарда

~50% коллапс

~50% тромбоэмболия легочной артерии

}

Стенокардические боли носят характер ... {

~ колющих
= сжимающих, давящих за грудиной
~ постоянных ноющих в левой половине грудной клетки
~ интенсивных болей за грудиной, более 20 минут, не купирующихся приемом нитроглицерина
}

Укажите характерные симптомы инфаркта миокарда: {
~%50% постоянные ноющие боли за грудиной
~%50% сжимающие боли за грудиной
~%50% падение АД
~%50% резкая головная боль
}

Обмороку может предшествовать: {
= период дурноты
~ потемнение в глазах или мелькание «мушек»
~ онемение конечностей
~ потеря сознания
}

Длительность обморока – {
= несколько минут
~ несколько часов
~ несколько секунд
~ до суток
}

Анафилактический шок – это общая системная реакция, развитие которой ... {
~%50% не зависит от путей введения антигена
~%50% напрямую связано с путем введения антигена
~%50% зависит от дозы аллергена
~%50% не зависит от дозы аллергена
}

Гипертензивный криз характеризуется: {
~%50% резким спазмом кровеносных сосудов
~%50% резким расслаблением кровеносных сосудов
~%50% преимущественным поражением сосудов головного мозга
~%50% преимущественным поражением коронарных сосудов
}

Эпилептический припадок начинается с ... {
~ клонических судорог
= тонических судорог

- ~ гиперкинезов
 - ~ локализованных судорог
- }

При эпилептическом припадке в момент судорог: {

- ~%50% не следует жестко удерживать больного
 - ~%-50% следует жестко фиксировать больного к опоре, на которой он лежит
 - ~%50% следует удерживать больного так, чтобы предотвратить травму головы
 - ~%-50% следует удерживать больного так, чтобы предотвратить травму конечностей
- }

Основной задачей оказания помощи пострадавшему с эпилептическим припадком является ... {

- = предотвращение травмы головы
 - ~ введение противосудорожных препаратов
 - ~ предотвращение травмы опорно-двигательного аппарата
 - ~ прерывание развивающегося припадка
- }

К предобморочным симптомам относятся: {

- ~%-50% обострение слуха и зрения
 - ~%-50% гиперемия лица
 - ~%50% бледность кожи
 - ~%50% слабость, тошнота
- }

Клинические признаки обморока: {

- ~%50% внезапность развития
 - ~%-50% лихорадка
 - ~%50% кратковременность и обратимость
 - ~%-50% развивается постепенно
- }

Первая помощь при обмороке: {

- ~ пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой, расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего воздуха.
- ~ пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой, расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего воздуха, носу поднести ватку, смоченную нашатырным спиртом.
- = пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой, расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего воздуха, носу поднести ватку, смоченную нашатырным спиртом, обрызгать лицо холодной водой, согреть ноги или растереть их.
- ~ пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой,

расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего воздуха, носу поднести ватку, смоченную нашатырным спиртом, обрызгать лицо холодной водой.

~ пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой, расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего воздуха, носу поднести ватку, смоченную нашатырным спиртом, согреть ноги или растереть их.

}

Первая помощь при коллапсе: {

~ пострадавшего уложить на спину, нижнюю часть туловища и ноги несколько приподнять, дать понюхать нашатырный спирт, при сохраненном сознании дать пострадавшему крепкий горячий чай, к конечностям приложить грелки.

~ пострадавшего уложить на спину без подушки, дать понюхать нашатырный спирт, при сохраненном сознании дать пострадавшему крепкий горячий чай, к конечностям приложить грелки.

~ пострадавшего уложить на спину без подушки, нижнюю часть туловища и ноги несколько приподнять, дать понюхать нашатырный спирт, при сохраненном сознании дать пострадавшему крепкий горячий чай.

= пострадавшего уложить на спину без подушки, нижнюю часть туловища и ноги несколько приподнять, дать понюхать нашатырный спирт, при сохраненном сознании дать пострадавшему, если он в сознании, крепкий горячий чай, к конечностям приложить грелки.

~ пострадавшего уложить на спину без подушки, нижнюю часть туловища и ноги несколько приподнять, при сохраненном сознании дать пострадавшему крепкий горячий чай, к конечностям приложить грелки.

}

Первая помощь при коме: {

~ освободить дыхательные пути от слизи.

~ освободить дыхательные пути от слизи, рвотных масс.

~ освободить дыхательные пути от слизи, рвотных масс, инородных тел, провести искусственное дыхание методами «рот в рот».

~ освободить дыхательные пути от слизи, рвотных масс, инородных тел, провести искусственное дыхание методами «рот в нос».

= освободить дыхательные пути от слизи, рвотных масс, инородных тел, провести искусственное дыхание методами «рот в рот», «рот в нос».

}

Признаки коллапса: {

~ бледность кожи, покрытой липким холодным потом, мраморно-синий цвет конечностей спадение вен и их неразличимость под кожей, западение глаз и заострение черт лица.

~ бледность кожи, покрытой липким холодным потом, мраморно-синий цвет конечностей спадение вен и их неразличимость под кожей, западение глаз и заострение черт лица, резко падение артериального давления.

с. бледность кожи, покрытой липким холодным потом, мраморно-синий цвет конечностей спадение вен и их неразличимость под кожей, западение глаз и заострение черт лица, резко падение артериального давления, отсутствие пульса или он едва прощупывается.

= бледность кожи, покрытой липким холодным потом, мраморно-синий цвет конечностей спадение вен и их неразличимость под кожей, западение глаз и заострение черт лица, резко падение артериального давления, отсутствие пульса или он едва прощупывается, учащенное, поверхностное, иногда прерывистое дыхание.

~ бледность кожи, покрытой липким холодным потом, мраморно-синий цвет конечностей спадение вен и их неразличимость под кожей, западение глаз и заострение черт лица, резко падение артериального давления, отсутствие пульса или он едва прощупывается, учащенное дыхание.

}

Первая помощь при отравлении сильнодействующими ядами: {

= срочно вызвать рвоту, предварительно дать пострадавшему выпить 1...2 стакана теплой воды, повторить эту процедуру 5...6 раз, после чего дать выпить 3...4 таблетки активированного угля, затем дать выпить слабительное, при возбуждении пострадавшего положить на голову холодный компресс и постараться удержать его в постели, при необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до полного восстановления сердечной деятельности, появления отчетливых сердцебиений и пульса.

~ срочно вызвать рвоту, после чего дать выпить 3 таблетки активированного угля, затем дать выпить слабительное, при возбуждении пострадавшего положить на голову холодный компресс и постараться удержать его в постели, при необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до полного восстановления сердечной деятельности, появления отчетливых сердцебиений и пульса.

с. срочно вызвать рвоту, предварительно дать пострадавшему выпить 4 стакана теплой воды, после чего дать выпить 3 таблетки активированного угля, затем дать выпить слабительное, при возбуждении пострадавшего положить на голову холодный компресс и постараться удержать его в постели, при необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до полного восстановления сердечной деятельности.

~ срочно вызвать рвоту, предварительно дать пострадавшему выпить 3 стакана теплой воды, повторить эту процедуру 7 раз, после чего дать выпить 3...4 таблетки активированного угля, затем дать выпить слабительное, при возбуждении пострадавшего положить на голову холодный компресс и постараться удержать его в постели, при необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до полного восстановления сердечной деятельности, появления отчетливых сердцебиений и пульса.

~ срочно вызвать рвоту, предварительно дать пострадавшему выпить 2 стакана теплой воды, повторить эту процедуру 5 раз, после чего дать выпить 4 таблетки активированного угля, затем дать выпить слабительное, при возбуждении

пострадавшего положить на голову холодный компресс и постараться удержать его в постели, при необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до полного восстановления сердечной деятельности, появления отчетливых сердцебиений.

}

Признаки комы: {

~ бледность лица, медленный пульс.

= бледность лица, медленный пульс, рвота, нарушение или отсутствие дыхания, непроизвольное мочеиспускание.

~ бледность лица, медленный пульс, рвота.

~ бледность лица, медленный пульс, рвота, нарушение дыхания.

~ бледность лица, медленный пульс, рвота, отсутствие дыхания.

}

Признаки комы: {

~ бледность лица, медленный пульс.

= бледность лица, медленный пульс, рвота, нарушение или отсутствие дыхания, непроизвольное мочеиспускание.

~ бледность лица, медленный пульс, рвота.

~ бледность лица, медленный пульс, рвота, нарушение дыхания.

~ бледность лица, медленный пульс, рвота, отсутствие дыхания.

}

Некроз (омертвление) участка миокарда имеет место при: {

=инфаркте миокарда

~стенокардии

~ кардиомиопатии

~миокардите

}

Первая медицинская помощь при истерическом припадке: {

~ Попытаться уговорить больного

=удалить посторонних, отвлечь пациента (уронить рядом что-либо, сбрызнуть лицо водой)

~ Подложить под голову одежду

~ После припадка обязательно сопроводить домой или в лечебное учреждение

}

Меры оказания первой медицинской помощи при приступе стенокардии: {

~анальгин внутрь

=нитроглицерин под язык.

~ холод на область сердца

~но-шпа внутрь

}

Учащенное сердцебиение это: {

= тахикардия
~брадикардия
~аритмия
~фибрилляция
}

Урежение ритма сердца это: {

~тахикардия
= брадикардия
~ аритмия
~фибрилляция
}

Повышение кровяного давления это: {

~атония
~тахикардия
~ гипотония
= гипертония
}

Понижение кровяного давления это: {

~атония
~тахикардия
= гипотония
~ гипертония
}

Тяжелая степень острой сосудистой недостаточности: {

= коллапс
~ обморок
~сердечная астма
~аритмия
}

При эпилептическом припадке необходимо: {

~удерживать больного, прижав к полу, между зубов вставить ложку
~уложить и дать успокаивающее средство
= недопустить получение травмы, между зубов положить кусок ткани, при западении языка – повернуть набок больного
~ перенести больного в спокойное место, удалить посторонних, ожидать окончания припадка
}

Симптомы стенокардии: {

= боли за грудиной, давящего характера, появляющиеся при физической и эмоциональной нагрузке, непродолжительные

~боли в области сердца интенсивного, сжимающего, давящего характера, продолжительные

~ боли за грудиной во время глотания, кратковременное

~ боли за грудиной длятся от 30 мин до нескольких часов, связаны с поражением позвоночника

}

Симптомы бронхиальной астмы: {

~ удушье, кашель с пенистой мокротой

~резкие боли за грудиной, чувство нехватки воздуха

= удушье с затруднением выдоха, свистящие хрипы слышны на расстоянии

~ резко выраженные головные боли, тошнота, рвота

}

Симптомы гипертонического криза: {

= резкое повышение АД, тошнота, сильная головная боль

~ бледные кожные покровы, покрытые липким холодным потом

~удушье, кашель с выделением пенистой мокроты

~тошнота, рвота, снижение артериального давления

}

Гипертонический криз – это осложнение: {

= гипертонической болезни

~стенокардии

~ инфаркта миокарда

~коллапса

}

При потере пострадавшим сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания первой помощи его необходимо уложить: {

~ На спину с подложенным под голову валиком.

~На спину с вытянутыми ногами.

=На бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой

~На живот

}

При потере сознания и понижении артериального давления без кровотечения необходимо: {

~Положить пострадавшего так, чтобы его голова и ноги были на одном уровне, дать обезболивающее.

~Положить пострадавшего так, чтобы его голова и ноги были на одном уровне, дать успокоительное.

= Положить пострадавшего так, чтобы его ноги были выше уровня головы.

~ Положить пострадавшего так, чтобы его голова была выше уровня ног

}

Действия в случае обморока (кратковременной потери сознания) пострадавшего?

{

~ Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень. Приподнять ноги. Надавить на болевую точку под носом.

~Приложить грелку к животу или пояснице. Надавить на болевую точку.

~ Ничего не предпринимать, вызвать врача.

~Напоить чаем и накормить.

= Убедиться в наличии пульса. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень. Приподнять ноги. Надавить на болевую точку.

Вызвать врача.

}

При тепловом ударе необходим: {

= пострадавшего раздеть, уложить на спину с приподнятыми конечностями и опущенной головой, положить холодные компрессы на голову, шею, грудь, дать обильное холодное питье;

~ уложить пострадавшего в постель, дать чай, кофе, в тяжелых случаях пострадавшего следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой;

~уложить пострадавшего в постель, дать холодные напитки, в тяжелых случаях пострадавшего следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой.

~ уложить пострадавшего в постель, дать кофе

}

При недостатке кислорода все живые ткани постепенно погибают. Особенно чувствителен к недостатку кислорода головной мозг. Через сколько минут без кислорода клетки мозга начинают необратимо погибать: {

~через 10-12 минут

~ через 8-10 минут

= через 5-7 минут

~через 3-4 минуты

}

Одной из основных причин инсульта может быть гипертоническая болезнь. Что это за болезнь?. {

~ разрыв патологически измененного кровеносного сосуда головного мозга

~это понижение артериального давления крови

= заболевание, характеризующееся повышением артериального давления крови
~ пониженный уровень кислорода в крови человека
}

Внезапное прекращение деятельности мозга или отдельных его частей из-за острого нарушения кровообращения или кровоизлияния — это: {

~инфаркт
= инсульт
~острая сердечная недостаточность
~судорога мозга
}

Какова последовательность оказания первой помощи при коллапсе: {

~пострадавшего уложить на живот, подложив подушку, нижнюю часть туловища и ноги несколько опустить, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, согреть ноги
~пострадавшего уложить на спину, подложив подушку, нижнюю часть туловища и ноги пострадавшего приподнять как можно выше, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, приложить лед к ногам
=пострадавшего уложить на спину, нижнюю часть туловища и ноги пострадавшего несколько приподнять, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, согреть ноги
~пострадавшего уложить на живот, подложив подушку, нижнюю часть туловища и ноги пострадавшего несколько приподнять, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, согреть ноги
}

Первая помощь при обмороке: {

~положить на бок, расстегнуть воротник, обеспечив приток свежего воздуха, дать пострадавшему нашатырный спирт, дать горячего сладкого чая
~уложить пострадавшего на пол, расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего воздуха, дать нашатырь, при отсутствии дыхания провести комплекс мероприятий по искусственному дыханию
=уложить на спину с откинутой головой назад, расстегнуть воротник, поднести к носу вату с нашатырным спиртом, обрызгать холодной водой лицо, согреть ноги
~пострадавшего уложить на живот, поднести к носу вату с нашатырным спиртом, обрызгать холодной водой лицо, согреть ноги
}

Внезапно возникающая потеря сознания - это: {

~ Шок;
= Обморок;
~Мигрень;
~ Коллапс.
}

